

Trauma i (złożony) zespół stresu pourazowego

Raport naukowy dla psychologów i neuropsychologów

dr inż. Mateusz Pomianek
3 lipca 2026 r.

Streszczenie

Trauma psychiczna nie jest pojedynczą diagnozą, lecz doświadczeniem przekraczającym aktualne możliwości regulacyjne człowieka i mogącym prowadzić do wielu odmiennych następstw. Najlepiej opisanymi zaburzeniami pourazowymi są zespół stresu pourazowego, określany skrótem PTSD, oraz złożony zespół stresu pourazowego, określany skrótem cPTSD. Raport przedstawia historię obu konstruktów, mechanizmy ryzyka i odporności, neurobiologię, neurochemię, objawy, codzienne funkcjonowanie, konsekwencje relacyjne, niejednoznaczną strategię, żałobę po dawnym obrazie siebie, zasady diagnozy oraz psychoterapię. Uwzględniono rozbieżności między DSM-5-TR a ICD-11, ograniczenia badań neuroobrazowych i biomarkerów oraz aktualne wytyczne terapeutyczne. cPTSD jest odrębną diagnozą w ICD-11, lecz nie występuje jako samodzielna jednostka w DSM-5-TR. W obu zaburzeniach podstawą diagnozy pozostaje wywiad kliniczny wsparty narzędziami standaryzowanymi. Najlepiej udokumentowane metody leczenia PTSD obejmują przedłużoną ekspozycję, terapię przetwarzania poznawczego i EMDR. W cPTSD często potrzebne jest rozszerzenie leczenia o regulację emocji, obraz siebie, relacje i integrację tożsamości. Niejednoznaczna strata i żałoba po dawnym sobie pomagają opisać kliniczne doświadczenia, które nie są odrębnymi rozpoznaniem, ale mogą istotnie utrzymywać cierpienie.

Słowa kluczowe: trauma, PTSD, cPTSD, neurobiologia stresu, dysocjacja, psychoterapia traumy, ambiguous loss, diagnoza kliniczna

Wprowadzenie

W języku potocznym słowo „trauma” bywa używane jako synonim każdego przykrego doświadczenia. W psychologii klinicznej potrzebne jest bardziej precyzyjne rozróżnienie. Zdarzenie traumatyczne oznacza ekspozycję na śmierć, groźbę śmierci, poważne obrażenia, przemoc seksualną albo inne doświadczenie o skrajnie zagrażającym charakterze, zależnie od przyjętego systemu klasyfikacyjnego. Reakcja pourazowa jest natomiast zespołem zmian emocjonalnych, poznawczych, fizjologicznych i behawioralnych pojawiających się po zdarzeniu. PTSD lub cPTSD rozpoznaje się dopiero wtedy, gdy określony wzorec objawów utrzymuje się, powoduje istotne cierpienie lub zaburza funkcjonowanie i spełnia kryteria klasyfikacyjne.

Większość osób narażonych na traumę nie rozwija przewlekłego PTSD. Bezpośrednio po zdarzeniu częste są koszmary, pobudzenie, trudności ze snem, niechciane wspomnienia, rozdrażnienie i czasowe unikanie. U części ludzi objawy stopniowo słabną bez specjalistycznego leczenia. Patologizowanie wczesnych reakcji może zwiększać lęk i odbierać pacjentowi poczucie sprawczości. Jednocześnie bagatelizowanie utrzymujących się objawów opóźnia diagnozę i leczenie.

Termin „trauma złożona” opisuje zwykle długotrwałą lub powtarzalną ekspozycję, często zależnościową i interpersonalną, z której ucieczka była trudna. Nie jest on równoznaczny z cPTSD. Osoba po wielokrotnych traumach może spełniać kryteria PTSD, cPTSD, depresji, zaburzenia dysocjacyjnego, zaburzenia używania substancji lub nie spełniać kryteriów żadnej

diagnozy. Z kolei rozpoznanie cPTSD opiera się na obrazie objawowym, a nie wyłącznie na rodzaju wydarzenia.

Historia rozumienia urazu psychicznego

Od urazu fizycznego do urazu psychicznego

Pojęcie traumy wywodzi się z medycyny i pierwotnie odnosiło się do uszkodzenia ciała. W XIX wieku rozwój kolei, przemysłu i medycyny wojskowej ujawnił zespoły objawów występujących po katastrofach oraz bitwach mimo braku oczywistych obrażeń neurologicznych. Opisywano „railway spine”, nerwicę urazową, histerię i objawy konwersyjne. Spór dotyczył tego, czy przyczyną są mikrouszkodzenia układu nerwowego, psychologiczne znaczenie zdarzenia, podatność jednostki czy symulacja.

Pierre Janet wiązał następstwa traumy z rozpadem integracji pamięci, emocji i działania. Zygmunta Freud początkowo podkreślał rolę rzeczywistych doświadczeń traumatycznych, a następnie rozwinął szerszą teorię konfliktu psychicznego. Współczesne modele pamięci traumatycznej pozostają bliższe intuicji Janet niż dawnemu założeniu, że objaw jest wyłącznie symbolicznym wyrazem wypartego konfliktu.

Doświadczenia wojenne i narodziny diagnozy PTSD

Podczas I wojny światowej używano określenia „shell shock”, które sugerowało neurologiczny skutek eksplozji. Wkrótce zauważono, że podobne objawy występują również bez bezpośredniego urazu głowy. W czasie II wojny światowej mówiono o wyczerpaniu bojowym i reakcji stresowej. Badania ocalałych z Zagłady, jeńców wojennych, ofiar tortur i weteranów wojny w Wietnamie ujawniły trwale następstwa obejmujące nawracające wspomnienia, koszmary, unikanie, odrętwienie emocjonalne oraz nadmierne pobudzenie.

PTSD wprowadzono do DSM-III w 1980 roku. Była to istotna zmiana, ponieważ źródło zaburzenia umieszczono nie tylko w podatności jednostki, lecz także w zewnętrznym wydarzeniu. Kolejne wersje DSM poszerzały i modyfikowały kryteria. DSM-5 przeniósł PTSD z grupy zaburzeń lękowych do kategorii zaburzeń związanych z traumą i stresem, a DSM-5-TR zachował cztery klastry objawów: intruzje, unikanie, negatywne zmiany poznawcze i nastroju oraz zmiany pobudzenia i reaktywności (American Psychiatric Association, 2022).

Rozwój koncepcji złożonego PTSD

Judith Herman opisała następstwa długotrwałej przemocy i zniewolenia, które wykraczały poza klasyczny obraz PTSD. Proponowany konstrukt obejmował trudności w regulacji afektu, zmiany świadomości, negatywny obraz siebie, zaburzenia relacji, somatyzację i utratę systemu znaczeń. W pracach nad DSM-IV rozważano kategorię DESNOS, czyli zaburzeń po skrajnym stresie niewymienionych gdzie indziej, lecz nie wprowadzono jej jako samodzielnej diagnozy.

ICD-11 przyjęła bardziej oszczędny model. PTSD obejmuje trzy grupy objawów: ponowne przeżywanie w teraźniejszości, unikanie i utrzymujące się poczucie zagrożenia. cPTSD obejmuje

pełne kryteria PTSD oraz trzy grupy zaburzeń organizacji siebie: dysregulację emocji, trwale negatywny obraz siebie i trudności w relacjach. ICD-11 weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. DSM-5-TR nie wyodrębnia cPTSD, chociaż część jego obrazu może być kodowana w ramach PTSD, zwłaszcza z utrwalonymi negatywnymi przekonaniami, dysocjacją i trudnościami interpersonalnymi.

Epidemiologia i czynniki ryzyka

Częstość ekspozycji na zdarzenia potencjalnie traumatyczne jest znacznie większa niż częstość PTSD. W badaniach World Mental Health obejmujących 24 kraje 70,4% respondentów zgłosiło co najmniej jedno takie zdarzenie. Rozpowszechnienie PTSD w ciągu życia oszacowano na 3,9% w całej populacji i 5,6% wśród osób narażonych na traumę. Ryzyko silnie zależało od rodzaju zdarzenia i było szczególnie wysokie po przemocy interpersonalnej oraz doświadczeniach obejmujących intencjonalne skrzywdzenie człowieka (Koenen et al., 2017; Kessler et al., 2017).

Nie ma jednej uniwersalnej wartości rozpowszechnienia cPTSD. Metaanaliza reprezentatywnych prób populacji dorosłych, obejmująca 10 badań, oszacowała rozpowszechnienie ICD-11 PTSD na około 2%, a cPTSD na około 4% w krajach wysoko rozwiniętych bez ekspozycji wojennej. W populacjach dotkniętych wojną lub pochodzących z regionów o mniejszych zasobach wartości wzrastały odpowiednio do około 6% i 15% (Fung et al., 2025). Inna metaanaliza oszacowała globalną częstość cPTSD w potencjalnie narażonych populacjach na 6,2%, 95% CI [3,7%, 10,3%], a w próbach jawnie narażonych na traumę na 12,4%, 95% CI [7,7%, 19,3%] (Huynh et al., 2025). Różnice między wynikami odzwierciedlają odmienny dobór prób, ekspozycję, narzędzia oraz algorytmy diagnostyczne.

Najsilniejsze czynniki ryzyka obejmują intensywność i interpersonalny charakter traumy, wcześniejsze urazy, brak możliwości ucieczki, zagrożenie ze strony opiekuna, obrażenia fizyczne, niski poziom wsparcia społecznego, wcześniejsze zaburzenia psychiczne, ubóstwo, dyskryminację, przewlekły stres po zdarzeniu oraz utratę zasobów. Ryzyko zwiększają również nieadaptacyjne interpretacje, takie jak globalne samoobwinianie, przekonanie o trwałym uszkodzeniu i uznanie świata za całkowicie niebezpieczny. Czynniki ochronne obejmują bezpieczeństwo po zdarzeniu, wsparcie społeczne, możliwość nadania doświadczeniu spójnego znaczenia, zachowaną sprawczość, elastyczność regulacji emocji, sen i dostęp do skutecznego leczenia.

Wybrane wartości ilościowe i ich interpretacja

Dane liczbowe należy interpretować jako estymacje grupowe. Nie stanowią one prognozy dla pojedynczego pacjenta, a wyniki z prób klinicznych, wojskowych i populacyjnych nie są bezpośrednio wymienne. Poniższa synteza przedstawia wartości szczególnie przydatne w diagnozie, psychoedukacji i planowaniu leczenia.

Wskaźnik	Wartość	Źródło
Ekspozycja na co najmniej jedno zdarzenie	70,4% respondentów w 24 krajach	Kessler et al. (2017)

traumatyczne		
PTSD w ciągu życia	3,9% w populacji ogólnej; 5,6% wśród osób narażonych	Koenen et al. (2017)
ICD-11 PTSD w populacjach wysoko rozwiniętych bez wojny	około 2%	Fung et al. (2025)
ICD-11 cPTSD w populacjach wysoko rozwiniętych bez wojny	około 4%	Fung et al. (2025)
PTSD i cPTSD w populacjach dotkniętych wojną lub o mniejszych zasobach	około 6% i 15%	Fung et al. (2025)
Globalna estymacja cPTSD w potencjalnie narażonych próbach	6,2%; 95% CI [3,7%, 10,3%]	Huynh et al. (2025)
cPTSD w próbach jawnie narażonych na traumę	12,4%; 95% CI [7,7%, 19,3%]	Huynh et al. (2025)
cPTSD w próbach klinicznych	44,7%	Huynh et al. (2025)
cPTSD po przemoc domowej lub seksualnej	40,0%	Huynh et al. (2025)
cPTSD w próbach wojskowych	36,4%	Huynh et al. (2025)
cPTSD u personelu ratowniczego	7,4%	Huynh et al. (2025)
Współwystępowanie dużej depresji z PTSD	około 50% w wielu próbach epidemiologicznych i klinicznych	Flory i Yehuda (2015); Kessler et al. (1995)
Zaburzenie używania substancji w klinicznych próbach PTSD	najczęściej około 20–35%	Roberts et al. (2022)
Rezygnacja z psychoterapii PTSD w RCT	16%; 95% CI [14%, 18%], 116 badań	Lewis et al. (2020)
Objętość hipokampa w aktualnym PTSD	$d = -0,17$; $p = 0,00054$ względem osób po traumie bez PTSD	Logue et al. (2018)
Objętość ciała migdałowatego	$d = -0,11$; $p = 0,025$, wynik nieprzechodzący korekty Bonferroniego	Logue et al. (2018)
PTSD u osób z przewlekłym bólem uogólnionym	20,5%; 95% CI [9,5%, 39,0%]	Siqveland et al. (2017)
Zmiana PCL-5 sugerująca odpowiedź	spadek około 10 punktów; wynik poniżej 28 może wskazywać na zmianę klinicznie istotną	National Center for PTSD (2026)

Mechanizmy psychologiczne

Uczenie lęku i generalizacja zagrożenia

Trauma może bardzo szybko połączyć bodźce neutralne z reakcją alarmową. Zapach, dźwięk, pora dnia, określony typ pomieszczenia lub cecha twarzy zaczynają zapowiadać niebezpieczeństwo. W PTSD reakcja może generalizować się na bodźce jedynie częściowo podobne do pierwotnego zagrożenia. Unikanie przynosi krótkotrwałą ulgę, przez co jest wzmacniane, ale zarazem ogranicza możliwość uczenia się, że obecna sytuacja jest bezpieczna.

Pamięć traumatyczna

Wspomnienia traumatyczne bywają fragmentaryczne, silnie sensoryczne i słabo osadzone w czasie. Nie oznacza to, że wszystkie są dokładnym zapisem zdarzenia. Pamięć pozostaje rekonstrukcyjna i podatna na zniekształcenia. Klinicznie ważne jest to, że fragment wspomnienia może być odczuwany jako zdarzenie dziejące się teraz, a nie jako reprezentacja przeszłości. Terapia zmierza do aktualizacji znaczenia wspomnienia oraz powiązania go z informacją o zakończeniu zagrożenia.

Ocena poznawcza, wstyd i poczucie winy

Po traumie człowiek próbuje wyjaśnić, dlaczego zdarzenie nastąpiło i co mówi ono o nim samym. Wnioski mogą przyjmować formę „jestem słaby”, „nie można nikomu ufać”, „to przeze mnie”, „moje ciało mnie zdradziło” lub „nie zasługuję na bliskość”. Poczucie winy może dotyczyć działań podjętych w warunkach skrajnego zagrożenia, reakcji zamrożenia, przeżycia, gdy inni zginęli, albo braku możliwości ochrony bliskich. Wstyd jest bardziej globalny i dotyczy całej osoby. W cPTSD negatywny obraz siebie jest zwykle bardziej trwały, uogólniony i osadzony rozwojowo niż w typowym PTSD.

Dysocjacja

Dysocjacja obejmuje zakłócenia integracji świadomości, pamięci, tożsamości, emocji i percepcji ciała. Może przyjmować formę depersonalizacji, derealizacji, amnezji, odrętwienia lub poczucia obserwowania siebie z zewnątrz. DSM-5-TR pozwala określić podtyp PTSD z dominującą depersonalizacją lub derealizacją. Dysocjacja nie jest jednak równoznaczna z cPTSD i może występować także w innych zaburzeniach. W diagnozie trzeba odróżnić ją od napadów padaczkowych, skutków substancji, zaburzeń snu, psychozy i następstw urazu mózgu.

Neurobiologia i neurochemia

Zastrzeżenia interpretacyjne

Badania neurobiologiczne opisują różnice statystyczne między grupami, ale nie dostarczają obecnie pojedynczego biomarkera pozwalającego zdiagnozować PTSD u konkretnej osoby. Nie wiadomo również, czy każda obserwowana różnica jest skutkiem traumy, wcześniejszym czynnikiem podatności, korelatem objawów, skutkiem leczenia czy wpływem chorób współistniejących. Wyniki badań cPTSD są mniej liczne niż badań PTSD i często opierają się na małych próbach.

Sieci mózgowe

Najczęściej opisywany model PTSD obejmuje zwiększoną reaktywność ciała migdałowatego i wyspy na sygnały zagrożenia, osłabioną regulację ze strony przyśrodkowej kory przedczołowej i przedniego zakrętu obręczy oraz zaburzenia funkcji hipokampa. Ciało migdałowe uczestniczy w wykrywaniu znaczenia emocjonalnego, ale nie jest prostym „ośrodkiem strachu”. Hipokamp wspiera pamięć kontekstową i odróżnianie podobnych sytuacji. Kora przedczołowa uczestniczy w hamowaniu reakcji, aktualizacji znaczenia i regulacji emocji. Największe wieloośrodkowe badanie ENIGMA-PGC wykazało jednak małe, a nie dramatyczne różnice morfometryczne: średnia objętość hipokampa była niższa przy aktualnym PTSD o $d = -0,17$, $p = 0,00054$. Dla ciała migdałowatego efekt wynosił $d = -0,11$, $p = 0,025$ i nie utrzymał się po korekcie Bonferroniego dla wielu porównań (Logue et al., 2018). Wielkości te potwierdzają znaczenie statystyczne na poziomie grup, lecz są zbyt małe i nieswoiste, by służyć jako test diagnostyczny.

Na poziomie sieciowym opisuje się nieprawidłową koordynację sieci istotności, sieci wykonawczej i sieci stanu spoczynkowego. Sieć istotności może nadmiernie oznaczać bodźce jako ważne lub zagrażające. Sieć wykonawcza może mieć trudność z utrzymaniem uwagi i kontrolą reakcji przy wysokim pobudzeniu. Sieć stanu spoczynkowego, związana między innymi z autobiograficznym poczuciem siebie, może wykazywać zaburzenia spójności. Taki obraz jest zgodny z klinicznym doświadczeniem chwiejnej uwagi, intruzji, odłączenia od siebie i problemów z odróżnianiem przeszłości od teraźniejszości, ale nie jest swoisty wyłącznie dla PTSD.

Oś podwzgórze, przysadka, nadnercza

Oś HPA reguluje odpowiedź hormonalną na stres. Podwzgórze wydziela kortykoliberynę, przysadka hormon adrenokortykotropowy, a nadnercza kortyzol. W PTSD często opisywano zwiększoną wrażliwość receptorów glikokortykoidowych i silniejsze sprzężenie zwrotne, czasem współistniejące z prawidłowym lub obniżonym poziomem kortyzolu podstawowego. Wyniki nie są jednak jednolite. Zależą od pory pomiaru, płci, rodzaju traumy, leków, depresji, snu i czasu od zdarzenia. Nie należy zatem przedstawiać PTSD jako prostego „niedoboru” lub „nadmiaru” kortyzolu.

Układ noradrenergiczny, serotonergiczny i dopaminergiczny

Nadmierna aktywność noradrenergiczna jest wiązana z hiperczunością, reakcją przestachu, koszmarami i trudnościami ze snem. Miejsce sinawe może zwiększać gotowość do wykrywania zagrożenia, a adrenalina i noradrenalina wzmacniają kodowanie emocjonalnie istotnych zdarzeń. Serotonina uczestniczy w regulacji nastroju, impulsywności i lęku. Skuteczność części inhibitorów wychwyty zwrotnego serotoniny nie dowodzi jednak, że PTSD jest prostym skutkiem „niskiego poziomu serotoniny”. Dopamina wpływa na motywację, uczenie i ocenę znaczenia bodźców, a jej zaburzenia mogą przyczyniać się do anhedonii, drażliwości i nieprawidłowego uczenia o nagrodzie oraz zagrożeniu.

Glutaminian, GABA i plastyczność

Glutaminian jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym, a GABA głównym neuroprzekaźnikiem hamującym. Zaburzenie równowagi między pobudzeniem a hamowaniem może sprzyjać nadreaktywności, problemom ze snem i utrwalaniu pamięci lękowej. BDNF, czyli neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego, uczestniczy w plastyczności synaptycznej i uczeniu wygaszania. Wyniki badań obwodowych stężeń BDNF są niejednorodne i nie mają obecnie zastosowania diagnostycznego.

Stan zapalny, układ autonomiczny i sen

U części pacjentów stwierdza się podwyższone markery zapalne, takie jak CRP, interleukina 6 i TNF-alfa. Zależności są małe lub umiarkowane i silnie zależą od otyłości, palenia, snu, chorób somatycznych i depresji. Układ autonomiczny może pozostawać przesunięty w kierunku pobudzenia współczulnego, z wyższą reaktywnością sercowo-naczyniową i niższą

zmiennością rytmu serca. Przewlekłe zaburzenia snu pogarszają wygaszanie lęku, pamięć, kontrolę emocji i odporność metaboliczną. Koszmary oraz bezsenność są zatem nie tylko objawami, lecz również mechanizmami podtrzymującymi zaburzenie.

Obraz kliniczny PTSD

W DSM-5-TR PTSD wymaga ekspozycji spełniającej kryterium A oraz obecności objawów z czterech klastrów przez okres dłuższy niż miesiąc. Intruzje obejmują niechciane wspomnienia, koszmary, reakcje dysocjacyjne, silne cierpienie i reakcje fizjologiczne na przypomnienia. Unikanie dotyczy myśli, uczuć, rozmów, osób, miejsc i aktywności. Negatywne zmiany poznawcze i nastroju obejmują luki pamięciowe, negatywne przekonania, zniekształcone obwinianie, utrzymujące się emocje negatywne, spadek zainteresowań, wyobcowanie i trudność w odczuwaniu emocji pozytywnych. Zmiany pobudzenia obejmują drażliwość, zachowania ryzykowne, hiperuczulność, wzmożoną reakcję przestachu, trudności z koncentracją i snem (American Psychiatric Association, 2022).

ICD-11 definiuje PTSD wężej. Wymaga ponownego przeżywania zdarzenia w teraźniejszości, celowego unikania przypomnień i utrzymującego się poczucia zagrożenia. Każdy rdzeniowy klaster musi być reprezentowany, a objawy muszą powodować istotne zaburzenie funkcjonowania. Węższa definicja ma zwiększać użyteczność kliniczną, ale może identyfikować inną grupę niż DSM-5-TR.

Obraz kliniczny cPTSD

cPTSD w ICD-11 wymaga pełnych objawów PTSD oraz utrwalonych zaburzeń organizacji siebie. Dysregulacja emocji może oznaczać nadmierną reaktywność, długie utrzymywanie się emocji, wybuchy złości, samouszkodzenia albo przeciwny wzorzec odrętwienia i odłączenia. Negatywny obraz siebie obejmuje przekonania o własnej bezwartościowości, porażce lub trwałym uszkodzeniu, zwykle z głębokim wstydem, winą lub poczuciem przegranej. Trudności relacyjne obejmują problem z utrzymaniem więzi, zaufaniem, bliskością i poczuciem przynależności.

cPTSD częściej rozwija się po długotrwałych lub powtarzalnych doświadczeniach, z których ucieczka była trudna, takich jak przemoc domowa, wykorzystywanie w dzieciństwie, tortury, handel ludźmi lub niewola. Nie jest jednak poprawne twierdzenie, że PTSD powstaje wyłącznie po pojedynczym zdarzeniu, a cPTSD wyłącznie po traumie wielokrotnej. O rozpoznaniu decyduje konfiguracja objawów i upośledzenie funkcjonowania.

Najważniejsze różnice diagnostyczne

Obszar	PTSD w ICD-11	cPTSD w ICD-11
Objawy rdzeniowe	Ponowne przeżywanie w teraźniejszości, unikanie, poczucie zagrożenia	Pełne kryteria PTSD
Regulacja emocji	Może być zaburzona, lecz nie jest obowiązkowym odrębnym klastrem	Trwała i nasilona dysregulacja emocji
Obraz siebie	Może zawierać negatywne przekonania	Trwale negatywny, globalny obraz siebie
Relacje	Trudności mogą występować	Trwałe trudności w bliskości i

		podtrzymywaniu relacji
Typowy kontekst	Dowolne zdarzenie spełniające kryterium traumy	Często trauma długotrwała, powtarzalna i zależnościowa
DSM-5-TR	Rozpoznanie obecne	Brak odrębnego rozpoznania

Codzienne funkcjonowanie

Uwaga, pamięć i funkcje wykonawcze

Osoba z PTSD może zużywać znaczną część zasobów poznawczych na monitorowanie zagrożenia, tłumienie wspomnień i kontrolowanie pobudzenia. W efekcie trudniej jej utrzymać uwagę, planować, przełączać się między zadaniami i zapamiętywać nowe informacje. Objawy mogą przypominać ADHD, zaburzenia poznawcze w depresji lub następstwa urazu mózgu. Neuropsycholog powinien analizować czas początku trudności, zależność od pobudzenia, jakość snu, działanie leków i ważność wykonania testu.

Wyniki badań neuropsychologicznych wskazują przeciętnie na niewielkie lub umiarkowane osłabienie uwagi, pamięci werbalnej, szybkości przetwarzania i funkcji wykonawczych, lecz z dużym zróżnicowaniem indywidualnym. Nie istnieje profil testowy swoisty dla PTSD. Bardzo słaby wynik nie powinien być automatycznie przypisywany traumie bez oceny neurologicznej, snu, depresji, używania substancji oraz wysiłku testowego.

Sen, ciało i zdrowie somatyczne

Bezsennność może obejmować trudność w zasypianiu, wybudzenia, lęk przed snem i odwrócenie rytmu dobowego. Koszmary bywają dosłownym odtworzeniem zdarzenia albo mają podobny temat emocjonalny. Pacjent może odkładać sen, pozostawiać włączone światło, sprawdzać zamki lub spać w ubraniu. Przewlekłe napięcie może nasilać ból, dolegliwości żołądkowo-jelitowe, bóle głowy i zmęczenie. Konieczna jest równoległa diagnostyka somatyczna, ponieważ objawy fizyczne nie powinny być uznawane za psychogenne wyłącznie na podstawie historii traumy.

Praca i edukacja

Trudności zawodowe wynikają z problemów z koncentracją, snem, tolerowaniem krytyki, przebywaniem w tłumie i reagowaniem na niespodziewane zmiany. Autorytarny przełożony, zamknięte pomieszczenie albo określony zapach mogą uruchamiać reakcję alarmową. Osoba może pracować nadmiernie, aby nie pozostawać sama z myślami, albo często przerywać zatrudnienie. W cPTSD dodatkowym obciążeniem jest przekonanie o niekompetencji, trudność w proszeniu o pomoc i przewidywanie odrzucenia.

Samoregulacja i zachowania ryzykowne

Alkohol, leki uspokajające, opioidy, kompulsywna praca, jedzenie, gry lub zachowania seksualne mogą pełnić funkcję krótkotrwałego tłumienia pobudzenia. Nie są one dowodem

słabości charakteru, lecz strategiami regulacyjnymi o wysokim koszcie. Leczenie wymaga jednoczesnego rozumienia funkcji zachowania i ograniczania szkód. Ostre uzależnienie, zatrucie lub odstawienie mogą wymagać priorytetowego leczenia medycznego.

Relacje, przywiązanie i seksualność

Trauma interpersonalna może zmienić podstawowe oczekiwania wobec innych. Bliskość zaczyna jednocześnie oznaczać potrzebę bezpieczeństwa i ryzyko zranienia. Osoba może intensywnie poszukiwać zapewnienia, a następnie wycofywać się, gdy relacja staje się ważna. Neutralna nieobecność partnera bywa interpretowana jako porzucenie, a drobna różnica zdań jako zapowiedź przemocy. Z drugiej strony hiperczułość może pozwalać wcześniej rozpoznawać realne sygnały zagrożenia. Terapeuta nie powinien automatycznie uznawać wszystkich obaw pacjenta za zniekształcenia poznawcze.

W relacjach częste są trudności z granicami. Jedna osoba może podporządkowywać się, aby zapobiegać konfliktowi, inna reagować gniewem na najmniejszą próbę kontroli. Reakcje „walk, flight, freeze, submit” nie są odrębnymi diagnozami, ale użytecznie opisują strategie obronne. W cPTSD utrwalony wstyd może prowadzić do ukrywania potrzeb, przekonania, że bliskość jest niezasłużona, oraz tolerowania krzywdzących relacji.

Seksualność może zostać powiązana z lękiem, odrętwieniem, bólem, utratą kontroli albo przymusem zadowalania partnera. Możliwa jest zarówno awersja seksualna, jak i zachowania kompulsywne. Praca kliniczna wymaga świadomej zgody, tempa kontrolowanego przez pacjenta, edukacji o reakcji zamrożenia i rozdzielenia pobudzenia fizjologicznego od zgody lub pragnienia. Fizjologiczna reakcja ciała podczas przemocy nie oznacza zgody i nie czyni osoby odpowiedzialną za zdarzenie.

Partnerzy i rodzina mogą doświadczać bezradności, przeciążenia i wtórnego stresu. Nie powinni przejmować roli terapeuty ani kontrolować pacjenta pod pozorem ochrony. Pomocne są jasne zasady reagowania na epizody, uzgodnione sygnały przerywania kontaktu, plan bezpieczeństwa oraz psychoedukacja. Terapia par może być rozważana, jeśli nie trwa przemoc i obie strony mogą swobodnie wyrażać zgodę. W aktywnie przemocowej relacji wspólna terapia może zwiększać zagrożenie.

Niejednoznaczna strata

Pauline Boss określiła niejednoznaczną stratę jako sytuację, w której brak jasności, kto lub co zostało utracone i czy strata jest ostateczna. W pierwszym typie osoba jest fizycznie nieobecna, lecz psychologicznie obecna, jak w przypadku zaginięcia, uprowadzenia lub migracji bez kontaktu. W drugim typie osoba jest fizycznie obecna, lecz psychologicznie niedostępna wskutek demencji, ciężkiego uszkodzenia mózgu, uzależnienia lub głębokiej zmiany po traumie (Boss, 1999, 2006).

W PTSD i cPTSD niejednoznaczność może dotyczyć bezpieczeństwa, relacji, sprawności, roli społecznej i obrazu siebie. Pacjent jednocześnie wie, że wydarzenie się zakończyło, i reaguje, jakby nadal trwało. Bliski człowiek może żyć, ale nie być już dostępny w dotychczasowy sposób. Rodzina może nie wiedzieć, czy oczekiwać powrotu wcześniejszego funkcjonowania, czy

przystosować się do trwałej zmiany. Brak jednoznacznego końca utrudnia społeczne uznanie żałoby i może podtrzymywać ruminacje.

Niejednoznaczna strata nie jest rozpoznaniem DSM-5-TR ani ICD-11. Nie ma jednej miary rozpowszechnienia, ponieważ konstrukt dotyczy wielu odmiennych sytuacji. Klinicznie ważne jest ograniczenie presji na „zamknięcie”. Terapia pomaga tolerować niepewność, rozdzielać obszary kontrolowalne od niekontrolowalnych, odbudowywać role i tworzyć rytuały uznające stratę. Celem może być życie z brakiem pełnej odpowiedzi, a nie jej sztuczne wytworzenie.

Żałoba po dawnym obrazie siebie

Określenie „żałoba po dawnym sobie” opisuje smutek związany z utratą wcześniejszego poczucia tożsamości, sprawności, spontaniczności, seksualności, zaufania lub przewidywanej przyszłości. Nie jest odrębną jednostką diagnostyczną ani terminem posiadającym jeden uzgodniony test. Może jednak trafnie opisywać doświadczenie pacjentów, którzy dzielą życie na okres przed traumą i po traumie.

Osoba może opłakiwać nie tylko to, kim była, lecz także to, kim mogła się stać. W traumie wczesnodziecięcej stabilne „ja sprzed traumy” mogło nigdy się nie rozwinąć. Przedmiotem żałoby staje się wtedy niezrealizowana możliwość bezpiecznego rozwoju. Towarzyszą temu gniew, zazdrość wobec osób żyjących bez podobnego obciążenia, wstyd z powodu spadku sprawności i przymus odzyskania dawnej produktywności.

Różnicowanie powinno uwzględniać depresję, przedłużone zaburzenie żałoby, depersonalizację, zaburzenia osobowości, skutki urazu mózgu i zaburzenia adaptacyjne. Terapia nie powinna obiecywać pełnego powrotu do osoby sprzed zdarzenia. Jej zadaniem jest uznanie rzeczywistych strat, korekta zniekształconej samooceny, odzyskiwanie wartościowych aktywności i zbudowanie ciągłości między przeszłym, obecnym i przyszłym obrazem siebie.

Narracja kintsugi

Kintsugi jest japońską praktyką naprawy ceramiki w sposób, który pozostawia linie pęknięć widoczne. W popularnej narracji psychologicznej spoinę przedstawia się jako złoto, a naprawiony przedmiot jako obiekt posiadający historię, której nie trzeba ukrywać. Metafora może wspierać integrację autobiograficzną, ponieważ sugeruje, że zdrowienie nie wymaga odtworzenia identycznego stanu sprzed urazu.

W zastosowaniu klinicznym pęknięcie może oznaczać uraz i utratę, a materiał łączący wsparcie, terapię, granice, wiedzę oraz odzyskaną sprawczość. Należy jednak precyzyjnie stwierdzić, że traumatyczne pęknięcie nie jest złotem. Wartość może mieć sposób odzyskiwania życia, a nie sama krzywda. Metafora nie jest zwalidowanym modelem psychoterapii i nie powinna zastępować konceptualizacji przypadku.

Narracja kintsugi staje się szkodliwa, gdy romantyzuje cierpienie, wymaga wdzięczności, narzuca wzrost potraumatyczny albo sugeruje, że pacjent powinien publicznie eksponować blizny. Wzrost potraumatyczny jest możliwy, lecz nieobowiązkowy. Samoopis pozytywnej zmiany nie zawsze oznacza obiektywną poprawę i może pełnić funkcję radzenia sobie. Poprawnym celem jest

integracja, czyli zdolność do pamiętania bez ciągłego przeżywania zdarzenia jako aktualnego zagrożenia.

Diagnoza kliniczna

Zasady postępowania

Diagnoza powinna rozpoczynać się od zapewnienia bezpieczeństwa, ustalenia aktualnego zagrożenia i oceny ryzyka samobójczego. Następnie należy zebrać historię ekspozycji, chronologię objawów, poziom funkcjonowania, choroby somatyczne, sen, leki, substancje, urazy głowy oraz kontekst kulturowy. Szczegółowe odtwarzanie zdarzenia nie jest konieczne podczas pierwszego spotkania, jeśli zwiększa destabilizację i nie wnosi informacji potrzebnej do decyzji klinicznej.

Kwestionariusz przesiewowy nie zastępuje wywiadu. Wynik powyżej punktu odcięcia oznacza podwyższone prawdopodobieństwo zaburzenia, a nie diagnozę. Punkty odcięcia zależą od języka, populacji, celu badania i kosztów błędów. W dokumentacji należy podać wersję narzędzia, źródło polskiej adaptacji, sposób obliczania i ograniczenia interpretacji.

Narzędzia dla PTSD

Narzędzie	Zakres	Sposób użycia i ograniczenia
CAPS-5	Ustrukturyzowany wywiad dla kryteriów DSM-5	Jest często uznawany za standard odniesienia. Ocenia obecność i nasilenie objawów, początek, czas trwania, cierpienie i funkcjonowanie. Wymaga szkolenia klinicznego.
PCL-5	20-itemowy samoopis objawów DSM-5	Służy do przesiewu i monitorowania zmiany. Często analizuje się sumę 0-80 oraz algorytm klastrowy. Punkt odcięcia należy dobierać do populacji.
LEC-5	Lista zdarzeń potencjalnie traumatycznych	Pomaga uporządkować ekspozycję. Nie mierzy PTSD i nie rozstrzyga automatycznie kryterium A.
PC-PTSD-5	Krótki przesiew w podstawowej opiece	Dodatni wynik wymaga dalszej oceny. Nie określa pełnego obrazu ani diagnozy różnicowej.
PSS-I-5	Wywiad oceniający objawy DSM-5	Może być używany do diagnozy i nasilenia, po odpowiednim przeszkoleniu.
IES-R	Samoopis intruzji, unikania i pobudzenia	Popularny w badaniach, ale nie odwzorowuje w pełni aktualnych kryteriów DSM-5 ani ICD-11.

Narzędzia dla PTSD i cPTSD według ICD-11

International Trauma Questionnaire jest krótkim narzędziem samoopisowym mierzącym rdzeniowe objawy PTSD, zaburzenia organizacji siebie i związane z nimi upośledzenie funkcjonowania. Umożliwia zastosowanie algorytmu prawdopodobnego PTSD lub cPTSD, lecz nie zastępuje oceny klinicznej. International Trauma Interview jest wywiadem klinicznym rozwijanym do diagnostyki PTSD i cPTSD zgodnie z ICD-11. Wybór polskiej wersji powinien opierać się na opublikowanej walidacji i warunkach licencyjnych.

Dysocjacja, depresja i funkcjonowanie

Dissociative Experiences Scale może wspierać przesiew dysocjacji, a Clinician-Administered Dissociative States Scale ocenę stanową. Skale te nie rozpoznają samodzielnie zaburzeń dysocjacyjnych. Depresję można monitorować za pomocą PHQ-9 lub BDI-II, lęk za pomocą GAD-7, sen za pomocą Insomnia Severity Index lub Pittsburgh Sleep Quality Index, a funkcjonowanie za pomocą WHODAS 2.0. Dobór powinien wynikać z hipotez klinicznych, nie z potrzeby mechanicznego rozbudowania baterii.

Ocena neuropsychologiczna

Badanie neuropsychologiczne jest wskazane, gdy zgłaszane są trwałe trudności poznawcze, wystąpił uraz głowy, istnieje podejrzenie choroby neurologicznej, potrzebna jest ocena zdolności do pracy lub plan rehabilitacji. Bateria powinna obejmować uwagę, szybkość przetwarzania, uczenie i pamięć, funkcje wykonawcze, język oraz funkcjonowanie wzrokowo-przestrzenne, zależnie od wskazania. Konieczna jest ocena trafności wykonania i wiarygodności objawów. Sam fakt niskiego wyniku w teście nie pozwala określić jego przyczyny.

Diagnoza różnicowa

Najczęstsze problemy różnicowe obejmują depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, ADHD, zaburzenie osobowości borderline, zaburzenia dysocjacyjne, psychozę, chorobę afektywną dwubiegunową, autyzm, zaburzenia używania substancji, przedłużone zaburzenie żałoby, urazowe uszkodzenie mózgu, padaczkę, bezdech senny i choroby endokrynologiczne. cPTSD i osobowość borderline mogą współwystępować. cPTSD częściej charakteryzuje się trwałym negatywnym obrazem siebie i unikaniem bliskości, natomiast borderline częściej obejmuje niestabilny obraz siebie, silny lęk przed porzuceniem, gwałtowne zmiany relacji i impulsywność. Rozróżnienie nie powinno opierać się na pojedynczym objawie.

Różnicowanie PTSD i cPTSD oraz zaburzenia współwystępujące

Znaczenie diagnozy różnicowej

Rozpoznanie PTSD lub cPTSD wymaga nie tylko potwierdzenia ekspozycji na zdarzenie o wyjątkowo zagrażającym lub przerażającym charakterze, lecz także wykazania charakterystycznej organizacji objawów. Sam wywiad traumatyczny nie przesądza o diagnozie. Podobnie pojedyncze koszmary, pobudzenie, wycofanie, trudności z koncentracją lub obniżony nastrój nie są swoiste dla zaburzeń pourazowych. Diagnoza różnicowa powinna ustalić związek czasowy objawów ze zdarzeniem, obecność ponownego przeżywania w poczuciu aktualności, unikania i utrzymującego się poczucia zagrożenia, a w przypadku cPTSD także trwałych zaburzeń regulacji emocji, negatywnego obrazu siebie i relacji.

Ocena powinna obejmować przebieg rozwojowy, funkcjonowanie przed traumą, chronologię objawów, aktualne zagrożenie, używanie substancji, choroby somatyczne, leki, urazy głowy, jakość snu oraz kulturowy sposób wyrażania cierpienia. Kwestionariusze przesiewowe nie

wystarczają do rozpoznania. Wynik PCL-5 lub ITQ wskazuje na prawdopodobieństwo określonego profilu, lecz nie zastępuje wywiadu klinicznego, oceny funkcjonalnej i różnicowania.

Ostra reakcja na stres, ostre zaburzenie stresowe i zaburzenie adaptacyjne

W pierwszych dniach po traumie silne pobudzenie, intruzje, unikanie, odrętwienie i zaburzenia snu mogą stanowić przemijającą reakcję stresową. W DSM-5-TR ostre zaburzenie stresowe rozpoznaje się od trzeciego dnia do jednego miesiąca po zdarzeniu. PTSD wymaga utrzymywania się objawów dłużej niż miesiąc. ICD-11 ujmuje ostrą reakcję na stres jako przejściową reakcję, a nie zaburzenie psychiczne. Kluczowe znaczenie ma więc czas, dynamika poprawy i poziom dysfunkcji.

Zaburzenie adaptacyjne rozwija się w odpowiedzi na możliwy do zidentyfikowania stresor, który nie musi spełniać kryterium traumy. Dominuje zaabsorbowanie stresem i trudność w przystosowaniu się do jego następstw. Nie występuje pełny, specyficzny wzorzec ponownego przeżywania, unikania i poczucia aktualnego zagrożenia. Jeżeli kryteria PTSD są spełnione, rozpoznanie zaburzenia adaptacyjnego nie powinno zastępować diagnozy pourazowej.

Depresja i zaburzenia lękowe

PTSD i epizod depresyjny mogą wspólnie obejmować anhedonię, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, poczucie winy, wycofanie i myśli samobójcze. W depresji obniżony nastrój i utrata zainteresowań są bardziej uogólnione oraz nie muszą pozostawać związane z przypomnieniami traumy. W PTSD centralne pozostają intruzje, unikanie i reakcja zagrożenia. Diagnozy mogą współwystępować, gdy oba pełne zespoły objawów są obecne. Przeglądy epidemiologiczne wskazują, że około połowa osób z PTSD spełnia obecnie lub w ciągu życia kryteria dużej depresji, chociaż estymaty różnią się zależnie od populacji, okresu pomiaru i użytego wywiadu (Flory & Yehuda, 2015; Kessler et al., 1995).

Uogólnione zaburzenie lękowe cechuje nadmierne zamartwianie się wieloma dziedzinami życia. W PTSD lęk jest silniej związany z pamięcią urazu, sygnałami przypominającymi i przewidywaniem ponownego zagrożenia. Napad paniki może wystąpić w obu zaburzeniach. W zaburzeniu panicznym napady są zwykle nieoczekiwane, a obawa koncentruje się na kolejnych napadach i ich konsekwencjach. W PTSD epizody paniki częściej są wyzwalane przypomnieniem traumy, chociaż współwystępowanie obu diagnoz jest możliwe. Fobia społeczna dotyczy przede wszystkim lęku przed oceną, natomiast unikanie w PTSD wynika z przewidywania zagrożenia lub aktywacji wspomnienia.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Natrętne wspomnienia traumatyczne bywają mylone z obsesjami. Intruzje PTSD odtwarzają lub symbolicznie reprezentują zdarzenie i często wywołują poczucie, że dzieje się ono ponownie. Obsesje są natomiast nawracającymi myślami, obrazami lub impulsami, które nie muszą odnosić się do rzeczywistego wydarzenia. Kompulsje służą neutralizowaniu lęku według

sztywnych reguł. Zachowania zabezpieczające w PTSD są zwykle podporządkowane unikaniu przypomnień i zapobieganiu ponownej traumie. Oba zaburzenia mogą współwystępować, dlatego należy ocenić funkcję zachowania, a nie tylko jego formę.

Przedłużone zaburzenie żałoby

Przedłużone zaburzenie żałoby jest skoncentrowane na śmierci bliskiej osoby. Dominują tęsknota, uporczywe zaabsorbowanie zmarłym, trudność w zaakceptowaniu śmierci i zaburzenie tożsamości związane ze stratą. W PTSD centrum obrazu klinicznego stanowią zagrożenie, groza i ponowne przeżywanie sposobu, w jaki doszło do zdarzenia. Po gwałtownej śmierci mogą współwystępować oba zaburzenia. W takim przypadku należy oddzielić tęsknotę i ból separacyjny od lękowego odtwarzania okoliczności śmierci.

cPTSD i zaburzenie osobowości z pogranicza

Najwięcej trudności budzi różnicowanie cPTSD z zaburzeniem osobowości z pogranicza. Oba obrazy mogą obejmować dysregulację emocji, samouszkodzenia, dysocjację, negatywny obraz siebie i problemy w relacjach. W cPTSD musi być obecny pełny rdzeń PTSD. Negatywny obraz siebie jest zwykle stabilnie zdominowany przez wstyd, poczucie bezwartościowości lub porażki, a relacje charakteryzuje unikanie bliskości, nieufność lub trudność w utrzymaniu więzi. W obrazie borderline częstsze są gwałtowne wahania obrazu siebie, intensywny lęk przed porzuceniem, niestabilne relacje z naprzemienną idealizacją i dewaluacją, impulsywność oraz nawracające zachowania samobójcze lub samouszkodzenia pełniące różne funkcje.

Różnice te mają charakter probabilistyczny, a nie absolutny. cPTSD i wzorec borderline mogą współwystępować. Historia przemocy nie wystarcza do zastąpienia diagnozy zaburzenia osobowości rozpoznaniem cPTSD, podobnie jak samouszkodzenia nie przesądzają o borderline. Badania klas latentnych i przeglądy systematyczne wspierają odrębność obu konstruktów, ale wskazują też na znaczące nakładanie się objawów.

Zaburzenia dysocjacyjne i psychozy

Depersonalizacja, derealizacja, amnezja i zmiany poczucia tożsamości mogą towarzyszyć PTSD lub wskazywać na odrębne zaburzenie dysocjacyjne. W dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości występują wyraźne nieciągłości poczucia siebie i sprawczości oraz nawracające luki pamięciowe wykraczające poza zwykłe zapominanie. W cPTSD zaburzenia tożsamości mają zazwyczaj postać trwałego negatywnego obrazu siebie, a nie odrębnych stanów tożsamości. Nasiloną dysocjację należy oceniać niezależnie, ponieważ wpływa na plan terapii i interpretację wyników neuropsychologicznych.

Flashback może być błędnie uznany za omam. W PTSD doświadczenie jest zwykle powiązane treściowo z traumą, pojawia się pod wpływem wyzwalacza i współlistnieje z innymi objawami pourazowymi. W psychozie omamy i urojenia mogą być bardziej autonomiczne wobec wspomnienia, towarzyszyć dezorganizacji myślenia, objawom negatywnym lub trwałemu zaburzeniu oceny rzeczywistości. Zachowany krytycyzm nie wyklucza żadnego z rozpoznań.

Konieczne jest także wykluczenie psychozy indukowanej substancjami, majaczenia, padaczki i innych stanów neurologicznych.

Choroba afektywna dwubiegunowa, ADHD i spektrum autyzmu

Drażliwość, bezsenność, impulsywność i wzrost aktywności mogą sugerować hipomanię lub manię. W chorobie afektywnej dwubiegunowej występują jednak wyraźne epizody zmiany nastroju i energii, obejmujące między innymi zmniejszoną potrzebę snu, przyspieszenie myślenia, wzrost pewności siebie i zachowania ukierunkowane na cel. Pobudzenie w PTSD ma częściowy charakter czujności obronnej, jest powiązane z zagrożeniem i nie prowadzi do typowego epizodycznego wzrostu napędu.

Trudności uwagowe, zapominanie, dezorganizacja i impulsywność występują zarówno w ADHD, jak i PTSD. ADHD rozpoczyna się w okresie rozwojowym, ujawnia w więcej niż jednym środowisku i nie jest wtórne wobec konkretnego urazu. W PTSD pogorszenie uwagi może pojawić się po traumie i zmieniać wraz z pobudzeniem, intruzjami i snem. U osoby z ADHD trauma może wyraźnie nasilić wcześniejsze deficyty, dlatego istotne są informacje szkolne, wywiad od rodziny i rekonstrukcja funkcjonowania przed zdarzeniem.

W spektrum autyzmu trudności społeczne, przeciążenie sensoryczne, potrzeba przewidywalności i epizody wycofania mają początek rozwojowy. W cPTSD problemy relacyjne są zwykle nabyte lub nasilone po traumie i łączą się z negatywnym obrazem siebie oraz poczuciem zagrożenia. Maskowanie cech autystycznych, częste doświadczenia wiktylizacji i aleksytymia mogą komplikować ocenę. Możliwe jest jednoczesne występowanie autyzmu i PTSD, a nietypowy sposób relacjonowania zdarzeń nie powinien być traktowany jako dowód niewiarygodności.

Urazowe uszkodzenie mózgu, zaburzenia snu i przyczyny somatyczne

Po łagodnym urazowym uszkodzeniu mózgu mogą wystąpić bóle głowy, zawroty, męczliwość, drażliwość, bezsenność, spowolnienie poznawcze i problemy z pamięcią. Objawy te silnie nakładają się na PTSD. Za uszkodzeniem neurologicznym przemawiają mechanizm urazu, utrata lub zaburzenie świadomości, niepamięć okołourazowa, objawy ogniskowe i udokumentowany przebieg neurologiczny. Sam prawidłowy wynik rutynowego badania obrazowego nie wyklucza łagodnego urazu mózgu. Równocześnie subiektywne skargi poznawcze po urazie są często wzmacniane przez PTSD, depresję, ból i zaburzenia snu, dlatego nie powinno się automatycznie przypisywać ich jednej przyczynie.

Bezdech senny, przewlekła bezsenność, nadczynność tarczycy, zaburzenia rytmu serca, padaczka, przewlekły ból, choroby autoimmunologiczne i działania niepożądane leków mogą naśladować lub nasilać pobudzenie, męczliwość i zaburzenia poznawcze. Diagnostyka psychologiczna powinna być uzupełniona konsultacją lekarską, gdy początek jest nagły, występują objawy neurologiczne, znaczna utrata masy ciała, omdlenia, nietypowe zaburzenia świadomości lub zmiana osobowości bez jasnego związku z traumą.

Substancje psychoaktywne i wiarygodność obrazu klinicznego

Alkohol, konopie, stymulanty, opioidy, leki uspokajające i objawy odstawienne mogą powodować lęk, bezsenność, drażliwość, zaburzenia pamięci, derealizację i objawy psychotyczne. Należy ustalić, czy objawy występowały przed użyciem, podczas intoksykacji, w okresie odstawienia oraz w czasie dłuższej abstynencji. Używanie substancji bywa próbą samoleczenia objawów PTSD, ale może też stanowić niezależne zaburzenie wymagające równoległego leczenia.

Ocena wiarygodności nie powinna opierać się na stereotypach dotyczących sposobu, w jaki osoba po traumie powinna opowiadać. Niespójności mogą wynikać z pobudzenia, dysocjacji, upływu czasu, snu, urazu głowy lub zwykłych właściwości pamięci. Jednocześnie w badaniach sądowych i rentowych należy rozważyć celowe wyolbrzymianie albo zaniżanie objawów, stosując triangulację danych, dokumentację, obserwację przebiegu i zwalidowane miary trafności objawowej. Żaden pojedynczy test nie rozstrzyga o symulacji.

Współwystępowanie innych zaburzeń

Współchorobowość w PTSD jest regułą częściej niż wyjątkiem. W klasycznym badaniu National Comorbidity Survey co najmniej jedno inne rozpoznanie w ciągu życia stwierdzono u około 88% mężczyzn i 79% kobiet z PTSD. Około 48% mężczyzn i 49% kobiet spełniało kryteria dużej depresji. Zaburzenia związane z alkoholem występowały u około 52% mężczyzn i 28% kobiet, a zaburzenia związane z innymi substancjami odpowiednio u około 35% i 27%. Dane te pochodzą z populacji Stanów Zjednoczonych i kryteriów DSM-III-R, dlatego nie należy ich bezpośrednio przenosić na każdą współczesną populację kliniczną.

Nowsze badania potwierdzają dużą częstość połączenia PTSD z depresją, zaburzeniami lękowymi, używaniem substancji, przewlekłym bólem i zaburzeniami snu, lecz wartości zależą od rodzaju traumy, płci, wieku i miejsca rekrutacji. W próbach osób leczonych z powodu zaburzeń używania substancji bieżące PTSD rozpoznaje się zwykle u około 15% do 42%, a rozpoznanie w ciągu życia u około 26% do 52%. W próbach osób z PTSD zaburzenie używania substancji innych niż alkohol opisywano u około 19% do 35%. W populacjach wojskowych i po wielokrotnej traumie wskaźniki bywają wyższe.

Dla cPTSD dostępne statystyki współchorobowości są mniej jednorodne. Wynika to z relatywnie krótkiego okresu stosowania diagnozy ICD-11, różnic między ITQ a wywiadem klinicznym oraz nadreprezentacji pacjentów po przemoc interpersonalnej w badaniach. Ogólny wzorzec wskazuje jednak, że cPTSD wiąże się z większym obciążeniem depresją, lękiem, dysocjacją, somatyzacją, używaniem substancji i trudnościami osobowościowymi niż PTSD. Nie oznacza to, że dodatkowe diagnozy są zawsze konieczne. Część objawów depresyjnych, interpersonalnych lub dysocjacyjnych może być elementem cPTSD, natomiast rozpoznanie współwystępujące należy postawić dopiero wtedy, gdy spełnione są jego pełne kryteria i wnosi ono odrębną informację kliniczną.

Współwystępowanie wiąże się na ogół z większym nasileniem objawów, wyższym ryzykiem samobójczym, gorszym funkcjonowaniem i bardziej złożonym planem leczenia. Nie

uzasadnia jednak automatycznego odkładania terapii skoncentrowanej na traumie. Priorytetem jest równoczesna ocena bezpieczeństwa, uzależnienia, psychozy, niestabilności afektywnej i problemów somatycznych oraz ustalenie, które mechanizmy aktualnie podtrzymują największą dysfunkcję.

Proponowany tok rozumowania klinicznego

Najpierw należy potwierdzić charakter zdarzenia i chronologię. Następnie ocenia się, czy występuje swoisty rdzeń PTSD, a w przypadku podejrzenia cPTSD także wszystkie trzy domeny zaburzeń samoorganizacji. Kolejny etap obejmuje analizę, czy podobne objawy występowały przed traumą, czy są epizodyczne, czy zależą od wyzwalaczy oraz czy można je lepiej wyjaśnić substancją, chorobą neurologiczną, zaburzeniem snu lub innym zaburzeniem psychicznym. Ostatecznie rozpoznaje się współchorobowość tylko wtedy, gdy drugi zespół ma własny przebieg, strukturę i znaczenie terapeutyczne. Taki tok postępowania ogranicza zarówno nadrozpoznanie PTSD, jak i pomijanie pourazowego źródła objawów.

Pourazowe strategie ochronne i mechanizmy obronne

Określenie „cechy wynikające z traumy” może błędnie sugerować niezmienną właściwość osobowości. W praktyce klinicznej częściej obserwuje się utrwalone strategie ochronne, które powstały w warunkach rzeczywistego zagrożenia i początkowo zwiększały szansę przetrwania. Po ustaniu zagrożenia mogą jednak działać automatycznie, ograniczać elastyczność zachowania i podtrzymywać objawy. Konceptualizacja powinna obejmować cztery pytania: przed czym dana reakcja chroniła, w jakim kontekście była skuteczna, jaki koszt powoduje obecnie oraz jaka bardziej elastyczna reakcja może przejąć jej funkcję.

Unikanie i zachowania zabezpieczające

Unikanie może dotyczyć miejsc, osób, rozmów, emocji, doznań cielesnych i wspomnień. Krótkoterminowo zmniejsza napięcie, lecz długoterminowo uniemożliwia aktualizację przekonania, że zagrożenie minęło. Podobną funkcję pełnią zachowania zabezpieczające, takie jak stałe sprawdzanie wyjść, siadanie wyłącznie tyłem do ściany, wielokrotne kontrolowanie zamków, prośenie o nieustanne zapewnienia lub całkowita rezygnacja z podróży. Nie każde zachowanie ostrożności jest patologiczne. Interwencji wymaga przede wszystkim reakcja nieproporcjonalna do aktualnego ryzyka, sztywna i istotnie ograniczająca funkcjonowanie.

Podstawowym ćwiczeniem jest funkcjonalny zapis sytuacji. Pacjent opisuje bodziec, przewidywaną katastrofę, poziom napięcia od 0 do 100, zastosowaną reakcję ochronną, natychmiastową ulgę oraz koszt po kilku godzinach lub dniach. Na tej podstawie wspólnie tworzy się hierarchię bezpiecznych sytuacji od najmniej do najbardziej obciążających. Ekspozycja ma polegać na stopniowym pozostawianiu w sytuacji przy ograniczaniu zachowań zabezpieczających, aż pacjent zgromadzi nowe informacje o rzeczywistym ryzyku i własnej zdolności radzenia sobie. Ekspozycji na wspomnienie traumatyczne nie należy prowadzić samodzielnie na podstawie ogólnego opisu. Wymaga ona pełnego protokołu, zgody pacjenta, monitorowania ryzyka i

kompetencji terapeuty w PE, terapii poznawczej, EMDR albo innej metodzie skoncentrowanej na traumie (Craske et al., 2014; Foa et al., 2019).

Hiperczułość, kontrola i perfekcjonizm ochronny

Hiperczułość oznacza nadmierne monitorowanie sygnałów zagrożenia, tonu głosu, mimiki, hałasów, zmian planu i możliwych oznak odrzucenia. U części pacjentów przyjmuje postać potrzeby pełnej kontroli, niechęci do delegowania, nadmiernego przygotowania lub perfekcjonizmu. Mechanizm opiera się na przekonaniu, że błąd, zaskoczenie lub zależność od innych prowadzą do krzywdy. W relacjach może skutkować interpretowaniem neutralnych zachowań jako zapowiedzi przemocy lub porzucenia.

Ćwiczenie terapeutyczne polega na oddzieleniu sygnału od interpretacji. Pacjent zapisuje obserwowalny fakt, automatyczną hipotezę, co najmniej dwie alternatywne interpretacje oraz dane, które mogłyby każdą z nich potwierdzić albo podważyć. Następnie przeprowadza mały eksperyment behawioralny, na przykład deleguje zadanie o niskim ryzyku, celowo pozostawia nieistotną czynność wykonaną wystarczająco dobrze albo spędza krótki czas bez sprawdzania otoczenia. Celem nie jest udowodnienie, że świat jest całkowicie bezpieczny, lecz uczenie proporcjonalnego szacowania ryzyka i tolerowania ograniczonej niepewności.

Tłumienie emocji, odrętwienie i intelektualizacja

Tłumienie emocji oraz odrętwienie mogą chronić przed przeciążeniem, wstydem i utratą kontroli. Intelektualizacja pozwala mówić o traumie wyłącznie językiem faktów, diagnoz lub teorii, bez kontaktu z osobistym znaczeniem doświadczenia. Strategie te bywają społecznie wzmacniane, ponieważ pacjent sprawia wrażenie spokojnego i dobrze funkcjonującego. Ich koszt może obejmować anhedonię, trudność w rozpoznawaniu potrzeb, napięcie somatyczne i ograniczoną bliskość.

Pracę rozpoczyna się od krótkiego nazywania emocji, a nie od intensywnego ich wywoływania. W ćwiczeniu trzech kanałów pacjent osobno opisuje myśli, emocje i doznania cielesne występujące w konkretnej sytuacji. Następnie ocenia natężenie emocji od 0 do 100 i formułuje potrzebę, którą emocja sygnalizuje. Przy małej świadomości emocjonalnej pomocne jest porównywanie kilku prawdopodobnych nazw zamiast żądania jednej poprawnej odpowiedzi. Uwaga na ciało powinna być krótka, dobrowolna i przerywana, gdy nasila derealizację, flashback lub panikę.

Dysocjacja i przedziałowe oddzielanie doświadczenia

Dysocjacja może obejmować depersonalizację, derealizację, luki pamięciowe, poczucie automatycznego działania oraz odłączenie emocji od narracji. Jest reakcją ochronną, gdy pełne doświadczanie zdarzenia przekraczało możliwości regulacji. W terapii nie należy traktować jej jako oporu ani wymuszać natychmiastowego dostępu do wspomnień. Pierwszym celem jest wcześniejsze rozpoznawanie sygnałów odłączenia i odzyskiwanie orientacji w teraźniejszości.

Ćwiczenie orientacyjne rozpoczyna się od podania na głos aktualnej daty, miejsca, wieku i informacji, że zdarzenie należy do przeszłości. Następnie pacjent wskazuje trzy neutralne obiekty w pomieszczeniu, opisuje ich kształt i położenie, dociska stopy do podłoża oraz wykonuje krótki ruch angażujący duże grupy mięśni. Można użyć chłodnego przedmiotu, wyraźnej faktury lub spokojnego kontaktu wzrokowego, jeżeli pacjent uznaje je za pomocne. Popularna procedura 5-4-3-2-1 może być użyteczna, ale nie jest uniwersalna. U niektórych osób intensywne kierowanie uwagi na zmysły albo oddech nasila objawy. Plan uziemiania powinien być sprawdzany empirycznie i dostosowany indywidualnie.

Podporządkowanie, zadowalanie innych i reakcja uległości

W przewlekłej przemocy bezpieczeństwo mogło zależeć od szybkiego rozpoznawania potrzeb sprawcy, unikania sprzeciwu i minimalizowania własnych potrzeb. W późniejszych relacjach strategia ta może przejawiać się automatyczną zgodą, trudnością w odmowie, przeproszaniem bez przyczyny, przejmowaniem odpowiedzialności za cudze emocje i lękiem przed konfliktem. Potoczne określenie „fawn” bywa użyteczne psychoedukacyjnie, ale nie jest kategorią diagnostyczną.

Przydatne ćwiczenie obejmuje skalę zgody. Przed odpowiedzią na prośbę pacjent zatrzymuje się i ocenia od 0 do 10, na ile rzeczywiście chce się zgodzić, jakiego kosztu się obawia po odmowie oraz czy zagrożenie jest aktualne, czy przypomina wcześniejszą relację. Następnie ćwiczy krótką odpowiedź: „Potrzebuję czasu do namysłu”, „Nie mogę się tego podjąć” albo „Mogę zrobić część zadania”. Początkowo wykorzystuje się sytuacje o małej stawce. Terapeuta analizuje nie tylko zachowanie, lecz także następującą po nim winę i potrzebę wycofania granicy.

Kompulsywna samowystarczalność i unikanie zależności

Pacjent może uważać, że prośenie o pomoc jest niebezpieczne, upokarzające lub bezcelowe. Samowystarczalność chroni przed rozczarowaniem i wykorzystaniem, ale prowadzi do przeciążenia oraz braku doświadczeń korygujących. Przeciwnym wzorcem jest rozpaczliwe poszukiwanie potwierdzenia i szybkie uzależnianie poczucia bezpieczeństwa od jednej osoby. Oba wzorce można rozumieć jako próbę regulacji zagrożenia w systemie przywiązania.

Ćwiczenie stopniowanego korzystania ze wsparcia polega na stworzeniu mapy osób i instytucji według rodzaju pomocy, wiarygodności i poziomu ryzyka. Pacjent wybiera niewielką, konkretną prośbę, formułuje ją bez usprawiedliwiania i obserwuje wynik. Po ćwiczeniu odróżnia faktyczną reakcję drugiej osoby od przewidywanej odmowy lub upokorzenia. Celem nie jest bezwarunkowe zaufanie, lecz różnicowanie osób, sytuacji i zakresów, w których zależność jest bezpieczna.

Wstyd, samoobwinianie i nadmierna odpowiedzialność

Samoobwinianie może dawać pozorne poczucie kontroli. Jeżeli pacjent uznaje, że mógł zapobiec zdarzeniu, świat wydaje się mniej losowy, a przyszłe bezpieczeństwo rzekomo zależy od

doskonałego zachowania. W cPTSD przekonanie to może przekształcić się w globalny obraz siebie jako osoby wadliwej, brudnej, słabej lub niegodnej bliskości. Interwencja musi odróżniać odpowiedzialność sprawcy, realne decyzje pacjenta, ograniczenia sytuacyjne i wiedzę dostępną dopiero po zdarzeniu.

W ćwiczeniu podziału odpowiedzialności pacjent identyfikuje wszystkie osoby, warunki i ograniczenia wpływające na zdarzenie, a następnie rozdziela między nie 100 procent odpowiedzialności. Kolejnym krokiem jest porównanie oceny własnego zachowania z oceną zachowania innej osoby o podobnych zasobach, wieku i dostępie do informacji. W CPT wykorzystuje się również analizę punktów utknięcia: pacjent zapisuje przekonanie, dowody za i przeciw, pominięty kontekst oraz bardziej zrównoważone sformułowanie. Nie chodzi o automatyczne pozytywne myślenie, lecz o precyzyjniejszą ocenę odpowiedzialności (Resick et al., 2017).

Złość, agresja ochronna i zamrożona reakcja obronna

Złość może sygnalizować naruszenie granic, ale w PTSD bywa uruchamiana przez bodźce jedynie podobne do dawnego zagrożenia. U części osób reakcja walki została w czasie traumy zahamowana i pojawia się później jako przewlekłe napięcie, drażliwość lub gwałtowne wybuchy. U innych dominują lęk przed własną złością i całkowite jej tłumienie. Celem terapii nie jest eliminacja złości, lecz odzyskanie wyboru sposobu jej wyrażenia.

Analiza łańcucha obejmuje zdarzenie wyzwalające, interpretację, pierwsze sygnały cielesne, impulsy, zachowanie i konsekwencje. Pacjent ustala osobisty próg przerwania, na przykład napięcie 60 na 100, i przygotowuje procedurę: nazwanie stanu, czasowe odejście bez porzucania rozmowy, ruch fizyczny o umiarkowanej intensywności, powrót o ustalonej godzinie oraz komunikat opisujący granicę. Przy przemocy wobec innych priorytetem jest plan bezpieczeństwa i specjalistyczne leczenie zachowań agresywnych, a nie samo ćwiczenie regulacyjne.

Podejrzliwość, testowanie relacji i trudność w bliskości

Po zdradzie, przemocy interpersonalnej lub zaniedbaniu pacjent może oczekiwać wykorzystania, odrzucenia albo nagłej zmiany zachowania drugiej osoby. Może wycofywać się przed zbliżeniem, wielokrotnie testować lojalność, interpretować opóźnioną odpowiedź jako porzucenie lub prowokować konflikt, aby uzyskać przewidywalny rezultat. Nie należy zakładać, że każda podejrzliwość jest zniekształceniem. Konieczna jest ocena realnej jakości relacji i aktualnej przemocy.

Ćwiczenie stopniowanego zaufania polega na rozdzieleniu zaufania na dziedziny, takie jak punktualność, poufność, odpowiedzialność finansowa, szacunek dla granic i wsparcie emocjonalne. Pacjent nie ocenia osoby globalnie jako bezpiecznej lub niebezpiecznej, lecz gromadzi obserwacje w każdej dziedzinie. W terapii par, gdy nie występuje przemoc ani kontrola przymusowa, pomocne mogą być ustalone procedury komunikacji, zapowiadanie przerw,

parafrazowanie treści oraz odróżnianie intencji od skutku. Terapia par jest przeciwwskazana jako podstawowe narzędzie naprawcze w relacji z trwającą przemocą.

Nadmierne osiągnięcia, produktywność i unikanie bezruchu

Ciągła aktywność może pełnić funkcję unikania wspomnień, doznań ciała i poczucia bezradności. Wysokie osiągnięcia nie wykluczają ciężkiego PTSD lub cPTSD. Pacjent może funkcjonować poprawnie zawodowo kosztem snu, relacji i wyczerpania, a odpoczynek interpretować jako utratę kontroli. Terapia obejmuje stopniowe uczenie odpoczynku jako zachowania bezpiecznego, a nie nagrody za całkowite wykonanie obowiązków.

Ćwiczenie wystarczająco dobrego działania polega na wybraniu zadania o małym znaczeniu i zakończeniu go po osiągnięciu wcześniej określonego kryterium, na przykład 80 procent oczekiwanej jakości. Pacjent zapisuje przewidywane konsekwencje oraz wynik rzeczywisty. Równolegle planuje krótki okres odpoczynku bez używania alkoholu, kompulsywnego przeglądania telefonu lub kolejnego zadania jako sposobu odciążenia emocji. Jeżeli bezruch uruchamia flashbacki, odpoczynek może początkowo mieć formę spokojnej, strukturalnej aktywności.

Ryzykowne zachowania i regulacja przez substancje

Alkohol, leki, narkotyki, ryzykowny seks, objadanie się, samouszkodzenia i zachowania impulsywne mogą szybko zmniejszać pobudzenie, odrętwienie lub wstyd. Ich funkcja regulacyjna musi zostać rozpoznana, ponieważ samo zakazanie zachowania pozostawia pacjenta bez narzędzia, które dotychczas działało natychmiast. Przy aktywnym uzależnieniu wskazane jest leczenie zintegrowane, które równolegle obejmuje PTSD i używanie substancji, zamiast automatycznego wymagania pełnej abstynencji przed każdą pracą nad traumą (Roberts et al., 2022). W próbach klinicznych zaburzenie używania substancji stwierdza się najczęściej u około 20–35% osób z PTSD, przy czym odsetki są wyższe w części populacji wojskowych i leczonych stacjonarnie. Zakres ten należy traktować jako przybliżenie zależne od definicji substancji, okresu obserwacji i miejsca badania (Roberts et al., 2022).

Praktyczne ćwiczenie obejmuje kartę impulsu. Pacjent zapisuje wyzwalacz, funkcję zachowania, przewidywaną ulgę, konsekwencje po godzinie i następnego dnia oraz co najmniej dwie alternatywy o podobnej funkcji. W ostrym kryzysie stosuje się plan bezpieczeństwa, ograniczenie dostępu do środków samouszkodzenia, kontakt z ustaloną osobą lub placówką i konkretne kroki przetrwania najbliższego okresu. Ćwiczenie nie zastępuje interwencji kryzysowej ani leczenia uzależnienia.

Psychoterapia

Podstawowe zasady

Aktualne wytyczne wskazują, że pierwszym wyborem w PTSD są indywidualne psychoterapie skoncentrowane na traumie. VA/DoD rekomenduje przede wszystkim przedłużoną

ekspozycję, terapię przetwarzania poznawczego i EMDR (Department of Veterans Affairs & Department of Defense, 2023). NICE rekomenduje terapię poznawczo-behawioralną skoncentrowaną na traumie oraz EMDR, zwykle w wymiarze od 8 do 12 sesji, z możliwością zwiększenia liczby spotkań przy wielu traumach i większej złożoności klinicznej (National Institute for Health and Care Excellence, 2018).

Przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić aktualną przemoc, ryzyko samobójcze, ostre zatrucie lub odstawienie, psychozę, niestabilność medyczną i możliwość utrzymania kontaktu z terażniejszością. Sama obecność dysocjacji, samouszkodzeń w wywiadzie lub diagnozy cPTSD nie jest automatycznym przeciwwskazaniem do pracy z pamięcią traumy. Tempo, forma i kolejność interwencji powinny być jednak dostosowane do funkcjonowania pacjenta.

Przedłużona ekspozycja

Przedłużona ekspozycja łączy ekspozycję wyobrażeniową na wspomnienie z ekspozycją in vivo na bezpieczne sytuacje, których pacjent unika. Powtarzany kontakt umożliwia uczenie hamujące i aktualizację przekonań o zagrożeniu. Typowy protokół obejmuje około 8-15 sesji, często trwających 90 minut. Terapia nie polega na zalewaniu pacjenta bodźcami ani na wymuszaniu szczegółów. Ekspozycja jest planowana, oparta na zgodzie i monitorowana.

Terapia przetwarzania poznawczego

Terapia przetwarzania poznawczego koncentruje się na punktach utknięcia, czyli sztywnych przekonaniach dotyczących winy, bezpieczeństwa, zaufania, kontroli, szacunku i bliskości. Standardowy protokół obejmuje około 12 sesji, lecz może być elastycznie dostosowany. Celem nie jest przekonanie pacjenta, że świat jest całkowicie bezpieczny, lecz zbudowanie bardziej zrównoważonych i funkcjonalnych ocen.

EMDR

EMDR obejmuje identyfikację docelowego wspomnienia, negatywnego przekonania, emocji i reakcji ciała, a następnie przetwarzanie przy naprzemiennej stymulacji bilateralnej. Metoda ma silne wsparcie empiryczne dla PTSD. Dyskusja naukowa dotyczy udziału ruchów oczu i mechanizmu obciążenia pamięci roboczej, lecz nie podważa skuteczności całego protokołu. NICE wskazuje zwykle 8-12 sesji, a większą liczbę przy traumach wielokrotnych.

Inne terapie

Written Exposure Therapy jest krótkim protokołem około pięciu sesji, opartym na uporządkowanym pisaniu o traumie. Narrative Exposure Therapy tworzy chronologiczną narrację życia i bywa szczególnie użyteczna przy licznych traumach, wojnie i uchodźstwie. Terapia poznawcza Ehlers i Clark koncentruje się na aktualnym poczuciu zagrożenia, charakterze pamięci i nieadaptacyjnych strategiach. Terapia skoncentrowana na terażniejszości nie wymaga szczegółowego przetwarzania wspomnienia i może być alternatywą, gdy pacjent nie wybiera terapii skoncentrowanej na traumie.

Leczenie cPTSD i podejście fazowe

Model fazowy obejmuje bezpieczeństwo i stabilizację, przetwarzanie wspomnień oraz integrację i rehabilitację relacyjną. Jest przydatny jako mapa kliniczna, lecz nie należy go stosować jako sztywnej reguły, która przez wiele miesięcy opóźnia skuteczną terapię traumy. Badania nie potwierdzają, że każda osoba po przemocy w dzieciństwie musi najpierw ukończyć długi trening stabilizacyjny. U części pacjentów krótkie przygotowanie wystarcza, u innych potrzebna jest równoległa praca nad bezpieczeństwem, samouszkodzeniami, regulacją emocji i relacjami.

STAIR rozwija rozpoznawanie emocji, strategie regulacji i kompetencje interpersonalne. Może być łączony z ekspozycją lub terapią narracyjną. Typowe programy badawcze obejmują około 16-20 sesji, lecz nie stanowi to uniwersalnego czasu leczenia cPTSD. Dłuższa terapia jest uzasadniona, gdy poza rdzeniowymi objawami występują poważne problemy tożsamościowe, dysocjacja, uzależnienie, niestabilność społeczna lub utrwalone trudności relacyjne.

Proces terapii

Pierwsza faza obejmuje diagnozę, konceptualizację, psychoedukację, plan bezpieczeństwa i wybór celów. Pacjent uczy się rozpoznawać okno tolerancji pobudzenia, sygnały eskalacji i metody orientowania się w teraźniejszości. Grounding nie jest leczeniem przyczyny PTSD, lecz narzędziem umożliwiającym udział w terapii.

W fazie przetwarzania pracuje się z pamięcią, znaczeniem zdarzenia, unikaniem i przekonaniami. Przejściowy wzrost dyskomfortu może wystąpić, ale nie powinien być traktowany jako warunek skuteczności. Terapeuta monitoruje objawy, funkcjonowanie, ryzyko i rezygnację. Przy narastającej destabilizacji modyfikuje dawkę ekspozycji, tempo, sposób pracy lub priorytety leczenia.

Faza integracji obejmuje relacje, seksualność, pracę, edukację, żałobę i tożsamość. Redukcja koszmarów i intruzji nie musi automatycznie przywrócić życia społecznego. Pacjent może potrzebować uczenia się granic, rozpoznawania bezpiecznych osób, tolerowania bliskości, planowania przyszłości i przeżywania straty bez dominującego wstydu.

Zasady doboru ćwiczeń

Ćwiczenie powinno wynikać z indywidualnej konceptualizacji, a nie z samej diagnozy. Terapeuta określa jego cel, przewidywany mechanizm zmiany, stopień trudności, sposób pomiaru oraz kryterium przerwania. Warto rozpoczynać od krótkiego testu podczas sesji, a dopiero później zalecać pracę własną. Brak wykonania zadania nie powinien być interpretowany moralnie. Może wskazywać na zbyt duży poziom trudności, niezrozumiały cel, brak warunków, reakcję dysocjacyjną albo konflikt między zadaniem a funkcją ochronną objawu.

Użyteczna struktura zadania obejmuje przewidywanie, wykonanie, obserwację i wnioski. Pacjent przed ćwiczeniem zapisuje, czego się spodziewa i z jakim prawdopodobieństwem. Po ćwiczeniu opisuje fakty, reakcję organizmu, zastosowane strategie zabezpieczające i to, czego doświadczenie nauczyło go o zagrożeniu, sprawczości lub relacji. Dzięki temu ćwiczenie nie staje się mechanicznym zaliczeniem, lecz źródłem nowych danych.

Plan bezpieczeństwa i stabilizacja

Plan bezpieczeństwa powinien być konkretny, dostępny poza gabinetem i okresowo aktualizowany. Zawiera indywidualne sygnały narastania kryzysu, czynności możliwe do wykonania samodzielnie, osoby i miejsca wspierające, kontakt do profesjonalnej pomocy oraz sposób ograniczenia dostępu do środków samouszkodzenia. W przypadku trwającej przemocy plan musi uwzględniać realia kontroli sprawcy, bezpieczeństwo urządzeń elektronicznych, dokumentów, dzieci i zwierząt. Nie należy konfrontować sprawcy ani ujawniać planu bez oceny ryzyka.

Stabilizacja nie oznacza całkowitego braku lęku ani perfekcyjnej regulacji. Wystarczającym kryterium rozpoczęcia pracy skoncentrowanej na traumie może być zdolność do wspólnego utrzymania planu bezpieczeństwa, pozostawania w kontakcie z terażniejszością przez większość sesji, zgłaszania przeciążenia i powrotu do względnej równowagi po aktywacji. Jeżeli tych możliwości brakuje, ćwiczenia przygotowawcze powinny być celowane i mieć kryteria oceny, aby stabilizacja nie stała się bezterminowym unikaniem.

Regulacja pobudzenia i oddechu

Ćwiczenia oddechowe mogą obniżyć pobudzenie autonomiczne, ale nie powinny być przedstawiane jako metoda usuwania wspomnienia. Bezpiecznym punktem wyjścia jest spokojny oddech z nieco dłuższym wydechem, na przykład wdech przez około cztery sekundy i wydech przez około sześć sekund, przez jedną lub dwie minuty. Nie zaleca się wymuszania bardzo głębokich oddechów ani długiego zatrzymywania powietrza, ponieważ mogą powodować zawroty głowy i zwiększać panikę. Pacjent ocenia napięcie przed i po ćwiczeniu. Gdy skupienie na oddechu wywołuje flashback lub odłączenie, lepiej zastosować ruch, orientację wzrokową albo kontakt z otoczeniem.

Praca z emocjami

W pracy z dysregulacją emocji przydatna jest sekwencja: rozpoznać, nazwać, dopuścić, sprawdzić funkcję i wybrać działanie. Pacjent uczy się, że emocja jest informacją i stanem czasowym, a nie poleceniem. W ćwiczeniu działania przeciwnego najpierw ocenia się, czy emocja odpowiada faktom. Jeżeli lęk dotyczy sytuacji obiektywnie bezpiecznej, działaniem przeciwnym jest stopniowe zbliżenie. Jeżeli złość nie odpowiada aktualnemu zagrożeniu, działaniem przeciwnym może być obniżenie tonu, rozluźnienie dłoni i sprawdzenie interpretacji. Gdy emocja odpowiada realnemu niebezpieczeństwu, właściwe jest działanie ochronne, a nie jej wygaszanie.

Restrukturyzacja poznawcza

Najbardziej użyteczne są przekonania konkretne, możliwe do sprawdzenia i powiązane z zachowaniem. Zamiast pracować nad ogólnym stwierdzeniem „jestem bezwartościowy”, terapeuta pomaga ustalić jego aktualne znaczenie, na przykład „jeżeli ujawnię potrzebę, zostanę odrzucony”. Analiza obejmuje źródło przekonania, kontekst, dowody, wyjątki, koszt oraz bardziej

trafną alternatywę. Alternatywne przekonanie powinno być wiarygodne, na przykład „nie każda osoba odpowie dobrze, ale mogę stopniowo sprawdzać, komu i w jakim zakresie zaufać”.

W przypadku myślenia dychotomicznego można użyć kontinuum. Pacjent zaznacza skrajne punkty, takie jak całkowita słabość i pełna siła, a następnie rozmieszcza na osi rzeczywiste zachowania własne i innych osób. W przypadku katastrofizacji przydatne jest porównanie najgorszego, najlepszego i najbardziej prawdopodobnego scenariusza oraz opracowanie planu radzenia sobie. W przypadku wiedzy po fakcie pacjent rekonstruuje informacje dostępne w chwili zdarzenia, bez używania późniejszej wiedzy.

Ekspozycja in vivo

Ekspozycja in vivo powinna dotyczyć sytuacji obiektywnie bezpiecznych, które są unikane z powodu skojarzenia z traumą. Terapeuta i pacjent definiują konkretne zadanie, przewidywany lęk, zachowania zabezpieczające i nowe informacje, które mają zostać sprawdzone. Ćwiczenie powtarza się w różnych kontekstach, ponieważ celem jest elastyczne uczenie bezpieczeństwa, a nie wyłącznie spadek napięcia w jednej sytuacji. Skuteczność nie wymaga pozostawiania do całkowitego wygaśnięcia lęku. Ważniejsze jest doświadczenie, że bodziec nie zawsze zapowiada krzywdę, a pacjent może działać mimo pobudzenia (Craske et al., 2014).

Przetwarzanie pamięci traumatycznej

Przetwarzanie wspomnienia powinno odbywać się w ramach zweryfikowanego protokołu. W PE pacjent wielokrotnie opowiada wspomnienie w czasie teraźniejszym, a następnie wspólnie z terapeutą analizuje nowe informacje. W terapii poznawczej rekonstruuje sekwencję zdarzenia, momenty największego zagrożenia i znaczenia, które podtrzymują poczucie aktualnego niebezpieczeństwa. W EMDR stosuje się ustrukturyzowany protokół obejmujący wspomnienie, negatywne i adaptacyjne przekonanie, emocje oraz doznania ciała. W NET zdarzenia zostają umieszczone na chronologicznej linii całego życia. Nie należy łączyć przypadkowych elementów tych metod bez odpowiedniego szkolenia.

W czasie przetwarzania terapeuta monitoruje orientację w teraźniejszości, poziom pobudzenia, dysocjację i zdolność do zakończenia sesji w zaplanowany sposób. Przejściowy wzrost napięcia jest możliwy, ale nie stanowi celu ani dowodu skuteczności. Jeżeli pacjent traci kontakt, nie pamięta znacznej części sesji, nie może odzyskać orientacji lub gwałtownie narasta ryzyko, należy zmniejszyć intensywność, skrócić odcinek materiału, zwiększyć zakotwiczenie w teraźniejszości albo ponownie ocenić plan leczenia.

Praca z relacjami i granicami

Ćwiczenie komunikacji granicy obejmuje opis faktu, własnej reakcji, potrzeby i konkretnej prośby. Przykład brzmi: „Kiedy rozmowa jest kontynuowana po mojej prośbie o przerwę, narasta moje napięcie. Potrzebuję dwudziestu minut przerwy i wrócę do rozmowy o ustalonej godzinie”. Terapeuta ćwiczy z pacjentem ton, długość wypowiedzi i reakcję na nacisk. Następnie analizuje,

czy druga osoba szanuje granicę. Terapia nie powinna uczyć pacjenta skuteczniejszego komunikowania się w celu przystosowania do przemocy.

W cPTSD pomocne jest rozpoznawanie relacyjnych wyzwalaczy. Pacjent opisuje bieżące zdarzenie, skojarzenie z wcześniejszą relacją, automatyczną rolę, na przykład uległe dziecko, opiekun albo napastnik, oraz możliwą reakcję osoby dorosłej w aktualnym kontekście. Ćwiczenie ma zwiększać wybór, nie usuwać potrzeb przywiązaniowych. W bezpiecznych relacjach można stopniowo trenować przyjmowanie pomocy, ujawnianie małych potrzeb i tolerowanie różnicy zdań bez natychmiastowego zerwania więzi.

Samowspółczucie i praca ze wstydem

Samowspółczucie nie oznacza usprawiedliwiania szkodliwych zachowań. Obejmuje realistyczne uznanie cierpienia, dostrzeżenie wspólnego ludzkiego wymiaru reakcji oraz życzliwy sposób odpowiadania sobie. W ćwiczeniu podwójnego standardu pacjent opisuje, co powiedziała by bliskiej osobie, która przeżyła podobne zdarzenie, a następnie porównuje to z językiem kierowanym do siebie. Kolejny krok polega na sformułowaniu odpowiedzi, która łączy odpowiedzialność z kontekstem i możliwością naprawy.

List współczujący może być adresowany do siebie z okresu bezpośrednio po traumie. Powinien zawierać opis tego, czego ta osoba nie wiedziała, jakie miała ograniczenia, czego potrzebowała i za co nie ponosi odpowiedzialności. Ćwiczenie bywa silnie aktywizujące, dlatego należy je najpierw przeprowadzić podczas sesji. U osób, dla których życzliwość była narzędziem manipulacji, łagodny ton może początkowo budzić nieufność. Wtedy lepiej rozpocząć od języka uczciwego i neutralnego niż od intensywnie ciepłych sformułowań.

Żałoba po dawnym obrazie siebie

Praca nad żałobą obejmuje rozróżnienie między tym, co zostało trwale utracone, co jest czasowo niedostępne, co można odbudować w zmienionej formie oraz co było idealizowanym obrazem przeszłości. Pomocne jest ćwiczenie czterech pól. Pacjent opisuje straty, zachowane elementy tożsamości, nowe możliwości i obszary nadal niepewne. Następnie wybiera jeden mały krok zgodny z wartością, którą chce zachować niezależnie od objawów.

Symboliczny list do dawnego siebie może zawierać uznanie utraconych możliwości, wdzięczność za strategie przetrwania, zgodę na smutek oraz określenie tego, co pacjent chce przenieść do obecnego życia. List nie musi prowadzić do pożegnania ani zamknięcia. W niejednoznacznej stracie celem jest zdolność do życia z brakiem pełnego rozstrzygnięcia, przy jednoczesnym odzyskiwaniu sprawczości w teraźniejszości.

Aktywacja behawioralna i odbudowa życia

Po redukcji unikania pacjent nadal może nie mieć struktury dnia, kontaktów i źródeł nagrody. Plan tygodniowy powinien obejmować aktywności związane z przyjemnością, kompetencją, relacją, odpoczynkiem i wartościami. Zadania muszą być wystarczająco małe, aby można je było wykonać także przy gorszym dniu. Po aktywności pacjent ocenia nie tylko nastrój,

ale również poczucie sensu, sprawczości i koszt energetyczny. Pozwala to uniknąć redukcji zdrowia do produktywności.

Sen i koszmary

Podstawowa interwencja obejmuje stałą porę wstawania, ograniczenie alkoholu i stymulantów, zmniejszenie czasu czuwania w łóżku oraz ocenę bezdechu, zespołu niespokojnych nóg i działań niepożądanych leków. W przypadku powtarzających się koszmarów można stosować Imagery Rehearsal Therapy. Pacjent zapisuje koszmar bez nadmiernego rozwijania szczegółów, tworzy zmienioną, mniej zagrażającą wersję zakończenia i ćwiczy jej wyobrażenie w ciągu dnia. Metoda wymaga ostrożności, gdy samo wyobrażanie gwałtownie nasila flashbacki lub dysocjację.

Plan utrzymania efektów

Pod koniec terapii pacjent i terapeuta tworzą indywidualny model nawrotu. Obejmuje on typowe wyzwalacze, wczesne sygnały, stare strategie ochronne, nowe odpowiedzi oraz moment, w którym należy ponownie skorzystać z profesjonalnej pomocy. Warto opisać różnicę między przejściowym nasileniem po stresie a pełnym nawrotem. Sesje przypominające mogą służyć ocenie utrzymania ekspozycji, przekonań, relacji i codziennego funkcjonowania.

Ograniczenia ćwiczeń i przeciwwskazania

Ćwiczenia samopomocowe nie powinny zastępować diagnozy i leczenia w przypadku nasilonego PTSD, cPTSD, psychozy, ciężkiej dysocjacji, aktywnej przemocy, znacznego ryzyka samobójczego lub niestabilnego uzależnienia. Nie należy zalecać samodzielnego odtwarzania najbardziej drastycznych wspomnień, konfrontowania sprawcy, wymuszonego przebaczenia ani praktyk mających „odzyskać” rzekomo wyparte wspomnienia. Medytacja, skanowanie ciała i zamykanie oczu nie są neutralne dla wszystkich pacjentów. Każde ćwiczenie powinno mieć możliwość przerwania, alternatywę oraz omówienie jego skutku.

Czas trwania i wyniki

Interwencja	Typowy protokół	Orientacyjny czas
Written Exposure Therapy	Około 5 sesji	Około 5-8 tygodni
Przedłużona ekspozycja	Około 8-15 sesji	Około 2-4 miesięcy
Terapia przetwarzania poznawczego	Około 12 sesji	Około 3 miesięcy
EMDR	Zwykle 8-12 sesji, więcej przy traumach wielokrotnych	Około 2-4 miesięcy lub dłużej
STAIR z terapią narracyjną lub ekspozycją	Często 16-20 sesji	Około 4-6 miesięcy
Leczenie wieloprognozowego cPTSD	Brak jednego standardu	Od kilku miesięcy do ponad roku, zależnie od obrazu klinicznego

Podane czasy opisują protokoły, a nie gwarantowany okres pełnego zdrowienia. Remisja objawów, poprawa funkcjonowania i integracja tożsamości mogą zachodzić w różnym tempie. W metaanalizie 116 randomizowanych badań psychoterapii PTSD średni odsetek rezygnacji wyniósł 16%, 95% CI [14%, 18%] (Lewis et al., 2020). Oznacza to, że około pięciu na sześciu uczestników pozostawało w badaniu do pomiaru po terapii, lecz wynik nie opisuje wszystkich warunków rutynowej praktyki. W badaniach weteranów wskaźniki bywają wyższe, dlatego skuteczność należy przedstawiać równocześnie z retencją, odsetkiem remisji i zmianą funkcjonowania.

Farmakoterapia jako uzupełnienie

Raport koncentruje się na psychoterapii, lecz w praktyce klinicznej farmakoterapia może być ważnym uzupełnieniem. Najlepiej udokumentowane leki dla PTSD obejmują sertralinę, paroksetynę i wenlafaksynę. Prazosyna może być rozważana w leczeniu koszmarów, chociaż wyniki badań są niejednorodne. Benzodiazepiny nie są zalecane jako rutynowe leczenie PTSD z powodu braku trwałej skuteczności dla objawów rdzeniowych, ryzyka tolerancji i uzależnienia oraz potencjalnego utrudniania uczenia w psychoterapii. Decyzje lekowe wymagają oceny lekarskiej, chorób współistniejących, interakcji i preferencji pacjenta.

Monitorowanie efektów

Postęp powinien być oceniany regularnie za pomocą tej samej miary, na przykład PCL-5 lub ITQ, oraz wskaźników funkcjonowania. Dla PCL-5 National Center for PTSD sugeruje spadek około 10 punktów jako praktyczny wskaźnik odpowiedzi na leczenie. Wynik poniżej 28 może wskazywać, że badana osoba jest statystycznie bardziej podobna do populacji bez klinicznego PTSD, ale interpretacja musi uwzględniać punkt wyjścia, błąd pomiaru i wywiad kliniczny (National Center for PTSD, 2026). Klinicznie ważna poprawa obejmuje również ograniczenie unikania, lepszy sen, odzyskanie ról społecznych i zmniejszenie ryzyka, nawet gdy wynik nie spada poniżej punktu odcięcia.

Ograniczenia i błędy kliniczne

Pierwszym błędem jest utożsamienie każdego trudnego doświadczenia z traumą diagnostyczną. Drugim jest uznanie, że brak pełnej pamięci zdarzenia dowodzi wyparcia. Trzecim jest traktowanie reakcji zamrożenia jako zgody lub bierności. Czwartym jest przypisywanie wszystkich objawów historii traumy, z pominięciem neurologii, chorób somatycznych, snu i substancji. Piątym jest automatyczne rozpoznawanie cPTSD wyłącznie na podstawie długotrwałej przemocy.

Należy unikać sugestywnych metod „odzyskiwania wspomnień”, ponieważ mogą zwiększać konfabulację i pewność wobec niezweryfikowanych treści. Pamięć traumatyczna może być fragmentaryczna, ale nie jest odporna na sugestię. Dokumentacja powinna oddzielać relację pacjenta, obserwację kliniczną, wyniki testów i wnioski diagnostyczne.

Kolejnym błędem jest przedłużanie stabilizacji bez jasno określonych celów i kryteriów przejścia do leczenia traumy. Przeciwnym błędem jest zbyt szybkie przetwarzanie wspomnień bez oceny bezpieczeństwa i zdolności do utrzymania kontaktu. Optymalne postępowanie wymaga wspólnego podejmowania decyzji, pomiaru efektów i elastycznej konceptualizacji.

Wnioski

PTSD jest zaburzeniem pamięci, znaczenia, reakcji zagrożenia i unikania, które może rozwinąć się po zdarzeniu o skrajnie zagrażającym charakterze. cPTSD w ICD-11 obejmuje dodatkowo trwałą dysregulację emocji, negatywny obraz siebie i zaburzenia relacji. Różnica nie sprowadza się do liczby traum. W obu przypadkach obraz kliniczny wynika z interakcji cech zdarzenia, wcześniejszego rozwoju, biologii, interpretacji, wsparcia społecznego i warunków po traumie.

Zmiany neurobiologiczne dotyczą przede wszystkim sieci wykrywania zagrożenia, regulacji przedczołowej, pamięci kontekstowej, osi HPA, układu autonomicznego i snu. Są to zależności grupowe, a nie testy diagnostyczne. Rozpoznanie wymaga wywiadu, oceny funkcjonowania, różnicowania i świadomego użycia narzędzi standaryzowanych.

Najlepiej udokumentowane leczenie PTSD stanowią psychoterapie skoncentrowane na traumie. W cPTSD często trzeba rozszerzyć je o regulację emocji, pracę z relacjami, wstydem i tożsamością. Niejednoznaczna strata i żałoba po dawnym obrazie siebie nie są odrębnymi diagnozami, ale mogą wyjaśniać utrzymujące się cierpienie po redukcji objawów rdzeniowych. Metafora kintsugi może wspierać integrację, jeśli nie romantyzuje krzywdy i pozostawia pacjentowi prawo do własnej interpretacji.

Bibliografia

- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787>
- Atkinson, J. R., Kristinsdottir, K. H., Lee, T., & Freestone, M. C. (2024). Comparing the symptom presentation similarities and differences of complex posttraumatic stress disorder and borderline personality disorder: A systematic review. *Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1037/per0000664>
- Bisson, J. I., Roberts, N. P., Andrew, M., Cooper, R., & Lewis, C. (2013). Psychological therapies for chronic post-traumatic stress disorder in adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2013(12), CD003388. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003388.pub4>
- Boss, P. (1999). *Ambiguous loss: Learning to live with unresolved grief*. Harvard University Press.
- Boss, P. (2006). *Loss, trauma, and resilience: Therapeutic work with ambiguous loss*. W. W. Norton.

- Brewin, C. R., Andrews, B., & Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 68(5), 748-766. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.68.5.748>
- Bryant, R. A. (2019). Post-traumatic stress disorder: A state-of-the-art review of evidence and challenges. *World Psychiatry*, 18(3), 259-269. <https://doi.org/10.1002/wps.20656>
- Cloitre, M., Garvert, D. W., Brewin, C. R., Bryant, R. A., & Maercker, A. (2013). Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: A latent profile analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 4(1), 20706. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v4i0.20706>
- Cloitre, M., Garvert, D. W., Weiss, B., Carlson, E. B., & Bryant, R. A. (2014). Distinguishing PTSD, complex PTSD, and borderline personality disorder: A latent class analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 5(1), 25097. <https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25097>
- Cloitre, M., Shevlin, M., Brewin, C. R., Bisson, J. I., Roberts, N. P., Maercker, A., Karatzias, T., & Hyland, P. (2018). The International Trauma Questionnaire: Development of a self-report measure of ICD-11 PTSD and complex PTSD. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 138(6), 536-546. <https://doi.org/10.1111/acps.12956>
- Cloitre, M., Stovall-McClough, K. C., Noonan, K., Zorbas, P., Cherry, S., Jackson, C. L., Gan, W., & Petkova, E. (2010). Treatment for PTSD related to childhood abuse: A randomized controlled trial. *American Journal of Psychiatry*, 167(8), 915-924. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09081247>
- Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. *Behaviour Research and Therapy*, 58, 10-23. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2014.04.006>
- Department of Veterans Affairs & Department of Defense. (2023). VA/DoD clinical practice guideline for management of posttraumatic stress disorder and acute stress disorder. <https://www.healthquality.va.gov/guidelines/MH/ptsd/>
- Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 38(4), 319-345. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(99\)00123-0](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(99)00123-0)
- Flory, J. D., & Yehuda, R. (2015). Comorbidity between post-traumatic stress disorder and major depressive disorder: Alternative explanations and treatment considerations. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 17(2), 141-150. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2015.17.2/jflory>
- Foa, E. B., Hembree, E. A., Rothbaum, B. O., & Rauch, S. A. M. (2019). *Prolonged exposure therapy for PTSD: Emotional processing of traumatic experiences* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Friedman, M. J., Keane, T. M., & Resick, P. A. (Eds.). (2021). *Handbook of PTSD: Science and practice* (3rd ed.). Guilford Press.

- Fung, H. W., Leousi, A., Chau, A. K. C., Sit, K. Y., Lam, C. C., Li, C. M., Huang, C. H. O., Cheung, C. T. Y., Lam, S. K. K., Wang, E. K. S., & Ho, G. W. K. (2025). Prevalence of ICD-11 post-traumatic stress disorder (PTSD) and complex PTSD in the general populations: A systematic review and meta-analysis. *Asian Journal of Psychiatry*. Advance online publication.
- Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery*. Basic Books.
- Huynh, P. A., Kindred, R., Perrins, K., de Boer, K., Miles, S., Bates, G., & Nedeljkovic, M. (2025). Prevalence of complex post-traumatic stress disorder (cPTSD): A systematic review and meta-analysis. *Psychiatry Research*, 351, Article 116586. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2025.116586>
- Kessler, R. C., Aguilar-Gaxiola, S., Alonso, J., Benjet, C., Bromet, E. J., Cardoso, G., Degenhardt, L., de Girolamo, G., Dinolova, R. V., Ferry, F., Florescu, S., Gureje, O., Haro, J. M., Huang, Y., Karam, E. G., Kawakami, N., Lee, S., Lepine, J. P., Levinson, D., ... Koenen, K. C. (2017). Trauma and PTSD in the WHO World Mental Health Surveys. *European Journal of Psychotraumatology*, 8(sup5), 1353383. <https://doi.org/10.1080/20008198.2017.1353383>
- Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M., & Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic stress disorder in the National Comorbidity Survey. *Archives of General Psychiatry*, 52(12), 1048–1060. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1995.03950240066012>
- Koenen, K. C., Ratanatharathorn, A., Ng, L., McLaughlin, K. A., Bromet, E. J., Stein, D. J., Karam, E. G., Meron Ruscio, A., Benjet, C., Scott, K., Atwoli, L., Petukhova, M., Lim, C. C. W., Aguilar-Gaxiola, S., Al-Hamzawi, A., Alonso, J., Bunting, B., Ciutan, M., de Girolamo, G., ... Kessler, R. C. (2017). Posttraumatic stress disorder in the World Mental Health Surveys. *Psychological Medicine*, 47(13), 2260–2274. <https://doi.org/10.1017/S0033291717000708>
- Lanius, R. A., Vermetten, E., & Pain, C. (Eds.). (2010). *The impact of early life trauma on health and disease: The hidden epidemic*. Cambridge University Press.
- Lewis, C., Roberts, N. P., Gibson, S., & Bisson, J. I. (2020). Dropout from psychological therapies for post-traumatic stress disorder (PTSD) in adults: Systematic review and meta-analysis. *European Journal of Psychotraumatology*, 11(1), Article 1709709. <https://doi.org/10.1080/20008198.2019.1709709>
- Linehan, M. M. (2015). *DBT skills training manual* (2nd ed.). Guilford Press.
- Logue, M. W., van Rooij, S. J. H., Dennis, E. L., Davis, S. L., Hayes, J. P., Stevens, J. S., Densmore, M., Haswell, C. C., Ipser, J., Koch, S. B. J., Korgaonkar, M., Lebois, L. A. M., Peverill, M., Baker, J. T., Boedhoe, P. S. W., Frijling, J. L., Gruber, S. A., Harpaz-Rotem, I., Jahanshad, N., ... Morey, R. A. (2018). Smaller hippocampal volume in

- posttraumatic stress disorder: A multisite ENIGMA-PGC study. *Biological Psychiatry*, 83(3), 244–253. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2017.09.006>
- Najavits, L. M. (2002). *Seeking safety: A treatment manual for PTSD and substance abuse*. Guilford Press.
- National Center for PTSD. (2026). PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5). U.S. Department of Veterans Affairs. <https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/ptsd-checklist.asp>
- National Institute for Health and Care Excellence. (2018). Post-traumatic stress disorder (NICE Guideline NG116). <https://www.nice.org.uk/guidance/ng116>
- Neff, K. D. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. *Self and Identity*, 2(2), 85-101. <https://doi.org/10.1080/15298860309032>
- Pitman, R. K., Rasmusson, A. M., Koenen, K. C., Shin, L. M., Orr, S. P., Gilbertson, M. W., Milad, M. R., & Liberzon, I. (2012). Biological studies of post-traumatic stress disorder. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(11), 769-787. <https://doi.org/10.1038/nrn3339>
- Resick, P. A., Monson, C. M., & Chard, K. M. (2017). *Cognitive processing therapy for PTSD: A comprehensive manual*. Guilford Press.
- Roberts, N. P., Lotzin, A., Schäfer, I., & Kitchiner, N. J. (2022). A systematic review and meta-analysis of psychological interventions for comorbid post-traumatic stress disorder and substance use disorder. *European Journal of Psychotraumatology*, 13(1), 2041831. <https://doi.org/10.1080/20008198.2022.2041831>
- Shapiro, F. (2018). *Eye movement desensitization and reprocessing therapy: Basic principles, protocols, and procedures* (3rd ed.). Guilford Press.
- Shin, L. M., & Liberzon, I. (2010). The neurocircuitry of fear, stress, and anxiety disorders. *Neuropsychopharmacology*, 35(1), 169-191. <https://doi.org/10.1038/npp.2009.83>
- Siqveland, J., Hussain, A., Lindstrøm, J. C., Ruud, T., & Hauff, E. (2017). Prevalence of posttraumatic stress disorder in persons with chronic pain: A meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 8, Article 164. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00164>
- Steenkamp, M. M., Litz, B. T., Hoge, C. W., & Marmar, C. R. (2015). Psychotherapy for military-related PTSD: A review of randomized clinical trials. *JAMA*, 314(5), 489-500. <https://doi.org/10.1001/jama.2015.8370>
- World Health Organization. (2022). *International statistical classification of diseases and related health problems* (11th rev.). <https://icd.who.int/>